

何廉臣 著

第五辑

现代著名老中医名著重刊丛书

小儿

诊法要义



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

现代医案选

泊庐医案

上海名医医案选粹

治验回忆录

内科纲要

六因条辨

马培之外科医案

中医外科证治经验

金厚如儿科临床经验集

 小儿诊法要义

妇科心得

妇科经验良方

沈绍九医话

著园医话

医学特见记

验方类编

应用验方

中国针灸学

金针秘传

现代著名老中医名著重刊丛书·第五辑

责任编辑 / 张永泰

封面设计 / 李 蹊

版式设计 / 陈 阮

责任校对 / 屈彦莉

ISBN 978-7-117-09582-2



9 787117 095822 >

定 价：10.00 元

附錄(CIP) 目錄編查并圖

现代著名老中医名著重刊丛书·《第五辑》

小儿诊法要义

何廉臣 著

第五卷

小儿诊法要义

100078

址: <http://www.paph.com>

E-mail: paph@paph.com

電話: 010-62528134 010-62528130

圖書市法印刷有限公司

PDG

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP)数据

小儿诊法要义/何廉臣著. —北京: 人民卫生出版社,
2008.1

(现代著名老中医名著重刊丛书 第五辑)

ISBN 978-7-117-09582-2

I. 小… II. 何… III. 中医儿科学 IV.R272

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 186237 号

现代著名老中医名著重刊丛书

第五辑

小儿诊法要义

著 者: 何廉臣

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编: 100078

网 址: [http://www. pmph. com](http://www.pmph.com)

E - mail: [pmph @ pmph. com](mailto:pmph@pmph.com)

购书热线: 010 - 67605754 010-65264830

印 刷: 三河市宏达印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 850 × 1168 1/32 印张: 3.5

字 数: 67 千字

版 次: 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-09582-2/R · 9583

定 价: 10.00 元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

出版说明

自 20 世纪 60 年代开始，我社先后组织出版了一批著名老中医经验整理著作，包括医论医话等。半个世纪过去了，这批著作对我国近代中医学术的发展产生了积极的推动作用，整理出版著名老中医经验的重大意义正在日益彰显，这些著名老中医在我国近代中医发展史上占有重要地位。他们当中的代表如秦伯未、施今墨、蒲辅周等著名医家，既熟通旧学，又勤修新知；既提倡继承传统中医，又不排斥西医诊疗技术的应用，在中医学发展过程中起到了承前启后的作用。这批著作均成于他们的垂暮之年，有的甚至撰写于病榻之前，无论是亲自撰述，还是口传身授，或是其弟子整理，都集中反映了他们毕生所学和临床经验之精华，诸位名老中医不吝秘术、广求传播，所秉承的正是力求为民除瘼的一片赤诚之心。诸位先贤治学严谨，厚积薄发，所述医案，辨证明晰，治必效验，不仅具有很强的临床实用性，其中也不乏具有创造性的建树；医话著作则娓娓道来，深入浅出，是学习中医的难得佳作，为近世不可多得的传世之作。

由于原版书出版的时间已久，已很难见到，部分著作甚至已成为学习中医者的收藏珍品，为促进中医临床和中医学术水平的提高，我社决定将一批名医名著编为《现代著名老中医名著重刊丛书》分批出版，以飨读者。

第一辑收录 13 种名著：

《中医临证备要》

《施今墨临床经验集》

《蒲辅周医案》

《蒲辅周医疗经验》

《岳美中论医集》

《岳美中医案集》

《郭士魁临床经验选集——杂病证治》

《钱伯煊妇科医案》

《朱小南妇科经验选》

《赵心波儿科临床经验选编》

《赵锡武医疗经验》

《朱仁康临床经验集——皮肤外科》

《张赞臣临床经验选编》

第二辑收录 14 种名著：

《中医入门》

《章太炎医论》

《冉雪峰医案》

《菊人医话》

《赵炳南临床经验集》

《刘奉五妇科经验》

《关幼波临床经验选》

《女科证治》

《从病例谈辨证论治》

《读古医书随笔》

《金寿山医论选集》

《刘寿山正骨经验》

《韦文贵眼科临床经验选》

《陆瘦燕针灸论著医案选》

第三辑收录 20 种名著：

《内经类证》

《金子久专辑》

《清代名医医案精华》

《陈良夫专辑》

《清代名医医话精华》

《杨志一医论医案集》

《中医对几种急性传染病的辨证论治》

《赵绍琴临证 400 法》

《潘澄濂医论集》

《叶熙春专辑》

《范文甫专辑》

《临诊一得录》

《妇科知要》

《中医儿科临床浅解》

《伤寒挈要》

《金匱要略简释》

《金匱要略浅述》

《温病纵横》

《临证会要》

《针灸临床经验辑要》

第四辑《方药中论医集》收录 6 种名著：

《辨证论治研究七讲》

《中医学基本理论通俗讲话》

《黄帝内经素问运气七篇讲解》

《温病条辨讲解》

《医学三字经浅说》

《医学承启集》

第五辑收录 19 种名著

《现代医案选》

《泊庐医案》

《上海名医医案选粹》

《治验回忆录》

《内科纲要》

《六因条辨》

《马培之外科医案》

《中医外科证治经验》

《金厚如儿科临床经验集》

《小儿诊法要义》

《妇科心得》

《妇科经验良方》

《沈绍九医话》

《著园医话》

《医学特见记》

《验方类编》

《应用验方》

《中国针灸学》

《金针秘传》

这批名著大多数品种原于 20 世纪 60 年代前后至 80 年代初在我社出版，自发行以来一直受到读者的广泛欢迎，其中多数品种的发行量都达到了数十万册，在中医界产生了很大的影响，对提高中医临床水平和中医事业的发展起到了极大的推动作用。

为使读者能够原汁原味地阅读名老中医原著，我们在重刊时采取尽可能保持原书原貌的原则，主要修改了原著中疏漏的少量印制错误，规范了文字用法和体例层次，在版式上则按照现在读者的阅读习惯予以编排。此外，为不影响原书内容的准

确性，避免因换算造成的人为错误，部分旧制的药名、病名、医学术语、计量单位、现已淘汰的检测项目与方法等均未改动，保留了原貌。对于犀角、虎骨等现已禁止使用的药品，本次重刊也未予改动，希冀读者在临证时使用相应的代用品。

人民卫生出版社

2007年11月

全书共8章35节，分列望诊纲要、问诊纲要、闻诊纲要、按诊纲要、检诊纲要、切脉纲要、总括六诊纲要、辨证纲要。何氏根据儿科疾病诊断特点，将四诊扩为六诊，颇有独到之处。书中所述，均用四言韵语，便于诵记。何氏出身中医世家，精通医术，学识广博，对于儿科病证，研究颇深，本书即体现了何氏精邃的理论与丰富的诊疗经验。书中所涉西医知识，虽有生硬之嫌，本书也不失为一本很有价值的参考书。



目录

第一章 望诊纲要	3
第一节 观形当诊体格	3
第二节 察色当参神气	5
第三节 望面部形色	5
甲、面现五色原理	6
乙、面色断病总诀	7
丙、面色察症要诀	8
丁、面分五部总诀	12
戊、面上五部热病	12
己、面诊五部形色要诀	13
第四节 望苗窍形色	18
甲、察两耳形色要诀	19
乙、察两目形色要诀	21
丙、察鼻孔形色要诀	23
丁、察口唇齿形色要诀	24
第五节 验舌苔形色要诀	26
第六节 察溲便形色要诀	31
第七节 望指纹形色	32
甲、辨指纹三关要诀	34
乙、辨指纹左右要诀	36

丙、辨指纹浮沉要诀	37
丁、辨指纹三关病势要诀	37
戊、辨指纹弯向病状要诀	38
己、辨指纹各色要诀	39
庚、辨指纹淡滞要诀	40
辛、辨色脉合参要诀	40
第二章 问诊纲要	42
第八节 问病因要诀	42
第九节 问诊十法要诀	43
甲、问寒热要诀	43
乙、问汗要诀	44
丙、问头身要诀	45
丁、问胸间要诀	48
戊、问饮食要诀	49
己、问睡眠要诀	50
庚、问饥渴要诀	50
辛、问溲便要诀	52
壬、问旧病要诀	53
癸、问遗传要诀	54
第三章 闻诊纲要	57
第十节 闻声音要诀	58
第十一节 闻啼哭要诀	59
第十二节 闻呼吸要诀	60
第十三节 闻咳声要诀	61

第十四节	闻痢声要诀	61
第十五节	闻语言要诀	62
第十六节	闻臭味要诀	63
第四章	按诊纲要	65
第十七节	按囟额要诀	65
第十八节	按胸腹要诀	66
第十九节	按冲任要诀	70
第二十节	按手足要诀	71
第二十一节	按冷热要诀	72
第五章	检诊纲要	75
第二十二节	检口腔要诀	75
第二十三节	检温度要诀	77
第二十四节	检阴器要诀	78
第二十五节	检便路要诀	79
第六章	切脉纲要	80
第二十六节	切头颈脉要诀	82
第二十七节	切手臂脉要诀	83
第七章	总括六诊纲要	86
第八章	辨证纲要	87
第二十八节	辨外感内伤要诀	87
第二十九节	辨寒热虚实要诀	88
第三十节	辨表里外内要诀	89
第三十一节	辨机变形势要诀	90

第三十二节	辨儿病险症要诀	94
第三十三节	辨儿病逆症要诀	95
第三十四节	辨五脏绝症要诀	96
第三十五节	辨婴童死症要诀	98

绪 论

尝览大梁阎季忠序《小儿药证直诀》云：医之为艺诚难矣，而治小儿为尤难。自六岁以下，黄帝不详载其说，始有《颅囟经》，以占寿夭生死之候，则小儿之病，虽黄帝犹难之，其难一也。脉法虽曰七八至为和平，九十至为有病，然小儿脉微难见，医为持脉，又多惊啼而不得其审，其难二也。脉既难凭，必资外证，而其骨气未成，形声未正，悲啼喜笑，变态不常，其难三也。问而知之，医之工也，而小儿多未能言，言亦未足取信，其难四也。脏腑柔弱，易虚易实，易寒易热，又所用多犀珠龙麝，医苟不能明辨，何以已疾？其难五也。种种隐奥，其难固多，余尝致思于此，又目见庸医妄施方药，而杀之者十常四五，良可哀也！余谓治小儿固难，治乳子为最难。盖以治病之难，难在识症。识症之难，难在诊断。爰将历代儿科名家诊断法，一一以证明之。宋儿科大家钱仲阳，首重面上证候，其次目内证候，又次小儿脉法，此钱氏注意望切两端，色脉合参之诊断术也。明婴科名家薛良武，注意三部五诊，三部者，面上形色，虎口指纹，寸口一指之脉；五诊者，上按额前，下按太冲，并前三部，此薛氏亦注重色脉合参，较钱氏明备之诊断术也。清婴科名家夏禹铸，注重以望为主，问继之，闻则次，切则无凭，间亦摹看指纹，了无征

验，此夏氏独重面色苗窍，不信指纹之诊断术也。清儿科专家张筱衫，注重视神气、审形色、诊面、察眼、察耳、察唇口、察齿、察鼻准、验舌苔、诊指纹、察手足、听声、按胸腹、询溲便、候脉等十五种要法，此张氏临病辨证较前三家尤为详备之诊断术也。若西医小儿诊断法，分望诊，切脉，检温，头部诊法，口内诊法，胸部诊法，腹部诊法，及既往症诊法，现症诊法，此西医与中医大同小异之诊断术也。合观中西诊法，诊断术之繁难如此。若畏其繁难而放弃之，则不能辨证，焉能治病；不能治病，焉能对症发药。故余不揣冒昧，于诊断术中西并参，敢以四十余年之经验，新纂而条分之。第一章，曰望诊纲要；第二章，曰问诊纲要；第三章，曰闻诊纲要；第四章，曰按诊纲要；第五章，曰检诊纲要；第六章，曰切脉纲要；第七章，曰总括六诊纲要；第八章，曰辨证纲要，约计三十五节。既分章节，更详条目，各著四言韵语，虽义尚简括，已足赅儿科诊断之要。使初学者便于诵习，易于记悟，此余新纂儿科诊断学之苦心也。汉张仲景《金匱要略》曰：上工望而知之，中工问而知之，下工切脉而知之。褚彦道《遗书》曰：博涉知病，多诊识脉，屡用达医。气生氏《医则》曰：诊断为治疗之始，又为治疗之终。横司乌氏曰：善诊断者善治病。明太祖谕徐达曰：更涉世故则智明，久历患难则虑周。吾侪临证诊断时最为然。有志研究儿科学者，尚期三复斯言。

小儿诊法要义

越中老医何廉臣印岩 撰述

男 幼 筱 廉 参校

第一章 望诊纲要

凡看儿病，以望为先，观形察色，一览了然，部位苗窍，分辨始全。

[参] 清·夏禹铸曰：凡小儿病有百端，逃不去脏腑气血；症虽多怪，怪不去寒热虚实；病纵难知，瞒不过颜色苗窍；症即难辨，莫忽略青白红黄。面上之颜色苗窍，乃脏腑血气发出来的；颜色之红黄青白，乃寒热虚实献出来的。业医道者，能于此处作功夫，细细详察，临症治病，必先以望面色，审苗窍为主，治无不神。

3

第一节 观形当诊体格

观形之要，首辨体格，强弱中等，必先鉴别。凡儿寿夭，病势顺逆，临症诊断，容易判决。

[参] 西医谓望诊以诊体格为第一，体格之良否，大有关于病之发生，以及日后病之可治不可治者也。医学上分体格为三种，曰强壮，曰虚弱，曰中等。强壮者，骨骼强大，胸廓广阔，筋肉坚细而不粗松，皮肤滑润而有光泽，其抵抗疾病之力大，虽罹重病，易于治疗。薄弱者，骨骼纤弱，胸廓狭小，筋肉瘦软，皮肤宽浮，其病虽幸一时治愈，然须防再发。中等者，介于上两体格之中间者也。其外貌有若柔弱，而其对于疾病之抵抗力，亦有强者，不可一概论之。医者或曰病虽重，体格尚强，不为大害；或曰病虽不可谓重大，因体格瘦弱之故，不可不注意者，皆据上三者而言也。万密斋云：小儿寿夭，须观形气，如形实气实者，此禀气有余，为寿相，无病易养；如形虚气虚者，此禀气不足，为夭相，多病难养。其歌括，一曰：头圆背厚腹如垂，目秀眉清鼻准齐，耳角分明口方正，骨坚肉实体丰肥。二曰：腮妍发绀形表端，二便调和里气安，脚健项肥囊紧小，肌肤温润更红鲜。三曰：性静神安状若愚，内含精采与人殊，乐然后笑不多哭，不露英华神气贮。以上三条，皆婴儿素体强壮之寿相也。平素无病，即偶患重病，治法适当，每转重而为轻，多顺少逆。四曰：颇解露缝眼露睛，鼻干唇缩口流津，发稀项软腓膈小，满面纷纷青紫筋。五曰：形憔悴表虚状，肚大筋浮里虚征，癍疥浸淫多叫哭，见人笑语弄精神。以上二条，皆婴儿素体薄弱之夭相也。平素多病，即偶患轻症，治法虽合，忽转轻而为重，多逆少顺。

第二节 察色当参神气

察色之妙，全在察神。得神者昌，失神者亡。寒则神静，热则神妄，虚则神衰，实则神旺。色见皮外，气含皮中，内光外泽，气色相融，有色无气，不病命倾，有气无色，虽困不凶。

[参] 张筱衫曰：神气为一身之主，神清气爽，神完气足，主清吉；神夺气移，神疲气浊，主夭亡。喻嘉言曰：人之五官百骸，赅而存者神居之耳。色者，神之旗也，神旺则色旺，神衰则色衰，神藏则色藏，神露则色露。故凡失睡之儿，神有饥色；丧亡之子，神有呆色，盖气索则神失所养耳。若隐然含于皮肤之内者为气，显然彰于皮肤之表者为色。《内经》谓气至色不至者生，色至气不至者死，以其有气无色，虽病不凶；有色无气，无病亦亡。

5

第三节 望面部形色

欲察外形，首相其面。面分五色，脏真可辨。肝青心赤，脾脏色黄，肺白肾黑，五脏之常。

[参] 面在头之前部，眉目口鼻在焉。察形首相其面者，谓脏腑之精华，皆著于面，或荣或悴，先可占验也。宋《小儿卫生总微论》曰：经言五脏之色皆外荣于面，故死生疾病系焉。其色不深不浅，应常光润者为和平，若色深浓者其脏实，浅淡者其脏虚。总之小儿面部

气色，为十二经总见之处，气血充实，五色显明为新病，证多轻而易治；气血虚弱，五色晦浊为久病，证属重而难治。

甲、面现五色原理

心主发血，血热鲜红，血瘀黯红，血虚淡红。肝主回血，其色淡青，络热青紫，络瘀青黑，甚则黧黑。脾主统血，其性恶湿，浅黄湿热，深黄积热，黯黄瘀热，萎黄虚热。肺主宗气，吸氧吐碳，多吸碳气，色必灰白（面无气色）；少吸氧气，色必眇白（面无血色）。肾司泌溺，故主滤血，血含浊质，面多泛黑。黑而明润，症犹可治；黑带油光，病多不吉；黑而枯焦，肾阴涸竭，黑而晦黯，肾阳败极。

[参] 人体内脏，各含色素，亦犹各种植物花叶中所含色素，均因感受日光，各呈其色彩也。经云：南方生热，其色赤。赤色西人亦云热色。经云：北方生寒，其色黑。黑色西人亦云冷色。再以五脏五色而精研之，肺主气，碳气呼出，氧气吸入，气清且洁，是肺含白素也。心主血，回血退换，新血化生，血鲜且红，是心含赤素也。肝制胆汁，其色绿，是肝含青素也。肾生外膜，其色紫黯，是肾含黑素也。脾居油网之上，脂肪皆其所司，一黯则变为黄矣。经以五色命五脏，具有至理寓乎其中，慎毋谓经旨之凿分脏色，为一无理由也。试述经义以阐发之，《内经》曰：面有青黄赤白黑，以应五脏。生于心，如以缟（素帛也）裹朱；生于肺，如以缟裹红（红谓淡红）；生于肝，如以缟裹绀（青含赤

色)；生于脾，如以缟裹栝楼实（黄含赤色）；生于肾，如以缟裹紫（黑含赤色）。此为无病之色，若病而色见，则以滋润而明亮者吉，枯槁而晦滞者凶。晦滞之色，上行者，病益甚；下行如云散者，病渐已；色散未聚，病亦未聚。女则色见右为逆，左为从，男子反此。

乙、面色断病总诀

先辨外感，风淫所胜，面青流涕；寒淫所胜，面白善嚏；暑淫所胜，面垢齿干；湿淫所胜，面黄色黯；燥淫所胜，嗌干面尘（面色灰败如尘垢也）；火淫所胜，面赤热盛。次论内伤，面色枯黯，新病可治；面脱色夭，久病不治。

总而言之，明显新病，晦浊久病，虽观表面，一望可凭。暴感外邪，不妨滞暗；久病内亏，反忌娇艳。红光润泽，少凶多吉；青黑黯惨，多凶少吉。洁白少神，虚脱宜防；干黄而憔，气液已亡。五色辨症，此为总诀，若欲精详，分辨宜晰。

[参] 清·蒋仲芳云：经谓望其五色以知其病，故望色者治人之首要也。《素问》以一色之中而分平病死三等，至《灵枢》又分明脏腑部分，及浮沉浅深夭泽散抟等法，盖以其道之不容忽也。爰为略陈其要，夫五色有光，明亮是也；五色有体，润泽是也。光者无形，为阳，阳主气；体者有象，为阴，阴主血。气血俱亡，其色沉晦枯槁，经所谓如草兹、枳实、衄血、枯骨五者是也。气血尚存，其色光明润泽，经所谓如翠羽、鸡冠、蟹腹、豕骨、鸟羽五者是也。此五色虽为可生，终

为一脏之色独亢，亢则害病也，非平也。盖平人五脏既和，其一脏之色，必待其旺而始荣于外。其荣于外也，禀胃气而出于皮毛之间。胃气色黄，皮毛色白，故云如缟裹。如缟裹者，朦胧光泽，虽有形影，犹未灿然。内因气血无乖，五脏无偏胜故也。苟或不然，五脏衰败，其见色也。昔之朦胧者，一变而为独亢；昔之光明者，一变而为沉浊；昔之润泽者，一变而为枯槁；甚至沉浊枯槁，合而为夭。是光体俱无，阴阳气血俱绝，不死又何待哉！观此，则五色之中，首贵内含神气。故前哲于望诊之中，一则曰神色，再则曰气色。神色者，内含光彩；气色者，内蕴精华。此皆阐发表面青黄赤白黑之原理，内容血色素之精义也。无论儿之幼小，病之新久，色有神气则生，色无神气则死，此为望色断诊之总诀。

丙、面色察症要诀

面青者痛，其病在肝；面青肢冷，定是胎寒；面青发搐，多属胎病，面青吐利，作慢脾看。久咳面青，肝纵乘肺；久泻面青，肝横乘脾。面青浅淡，肝虚本色；面青深浓，肝风病色。面青口噤，脘腹冷痛；面青唇赤，风温癰疽。太阳承浆、风池气池，各见色青，非惊则痉。青遮日角，惊厥最多；青掩印堂，惊泻沉痾。山根青紫，病多风热；环口青黑，症皆危急。凶赤印青，病机已重；凶印皆青，病势必凶。总而言之，青为厉色，面青目黄，面青目白，面青唇黑，多凶少吉。

[参] 青色属肝，主风主惊，主寒主痛。面唇皆青者，寒极也；青而脱色者，惊恐也。青而黑者多寒痛，

青而白者多虚风（以上皆寒症）。青而赤者为肝火，青赤而晦滞者为郁火（以上皆热症）。总之，青为残贼之色，暴露于面部，症既危急，命亦危险。

黄为脾色，病在胃肠。脾伤面黄，消化不良。面黄光润，痰饮湿热；面黄枯暗，寒湿食积。面黄而肥，胃有痰湿；面黄而瘠，胃有蕴热。面黄似橘，食伤吐泄；面黄若熏，阴疸脾湿。面黄色淡，胃气已弱；面黄色枯，胃液将涸。面黄而青，肝脾相克；面黄而黑，脾肾衰竭。面黄带白，中多疳积；面黄而浮，内藏癖积。面黄不润，多蟹爪纹，或多白点，皆属虫积。面黄而亮，目白如金，及溺黄赤，定是胎黄。眼角鼻准，及其人中，忽现黄色，此为脐风。总而言之，面黄光泽，为有胃气，预后皆吉。

[参] 黄色属脾，主湿热食积。黄而明如橘子者，湿少热多也；黄而暗如烟熏者，湿多热少也。黄而暗淡者，则为寒湿；黄而枯癯者，则为积热。黄而色淡者，胃气已虚，脾阳不健也；黄而青黑者，脾为寒滞，肾水上泛也。惟黄色见于面目，既不枯槁，又不浮泽，为欲愈之候。总之，黄为中央之色，其虚实寒热之机，又当以饮食便溺消息之。

赤色属心，面赤主热。其色嫩红，赤子本色；其色大红，是为胎热。浅赤表热，深赤里热。面带红光，外感风热；面若涂朱，心火盛极。面赤腮坚，营血本充；面赤肉坚，素禀火重，微赤而鲜，气虚有火；干赤而枯，血虚多火。乍红乍白，胃肠虫积；又赤又青，惊风纵掣。面赤深浓，营分实热；面赤浅淡，血分虚热。艳

红带白，泻痢戴阳；纯红带青，肝风上翔。总而言之，赤为火色，表里虚实，症多属热。

[参] 赤色属心，主热。面色缘缘正赤者，阳气怫郁在表，汗不彻故也（此伤寒太阳经表热证）。面赤而潮热谵语者，胃实也（此伤寒阳明经实热证）。面赤如微酡，或两颧浅红娇嫩，游移不定（不尽面通红），乃阴证戴阳，必下利清谷，或小便清白、或淡黄，脉沉细、或浮数无力按之欲散，虽或烦躁发热，欲坐卧泥水中（外热甚也），渴欲饮水，或咽喉痛，证似实热，而索水置前，却不能饮，肌表虽大热，而重按之则不热，或反觉冷，且两足必冷，必须细审（此伤寒直中寒证）。又有面赤烦躁，遍舌生疮生刺，舌敛缩如荔枝状，或痰涎涌盛喘急，小便频数，口干引饮，两唇焦裂，喉间如烟火上攻，两足心如烙，脉洪数无伦，按之无力，扪其身烙手，此心肾阴虚，火不归元所致，证最难辨。但病由内伤，其来以渐，是乃干柴烈火，不戢自焚，与上所列三证，因各不同也。又有久病虚人，两颧至午后带赤者，此则阴虚火动之常证，虽未至如上症之烈，而其颧赤则同为内伤也（以上二证皆虚热）。若赤色出于两颧，状若装朱，大如拇指者，病虽愈，必死。热病无汗，颧赤亦死。颧以骨为主，骨属肾水，火盛灼水而上升也。总之，赤为火炎之色，只虑津枯血竭，决无虚寒之患。大抵火形人从未有肥盛多湿者，即有痰嗽，亦燥气耳。

白色属肺，面白气虚。白而光泽，肺气有余；面色淡白，肺虚咳血；面色晄白，肺虚气脱。白如冠玉，气色俱足；面若傅粉，气色皆夺。面白皤皤，疴痨久泻；

面白惨惨，元阳将绝。白而兼赤，气虚血热；白而兼青，气寒血结。面多白点，大肠虫积；面现白痞，气分湿热。总而言之，白主气液，欲如豕膏，最忌枯骨。

[参] 色白属肺，白而淖泽，肺胃之充也。肥白而按之绵软，气虚有痰也。白而消瘦，爪甲鲜赤，气虚有火也。白而天然不泽，爪甲色淡，肺胃虚寒也。白而微青，或臂多青络，气虚不能统血。若兼爪甲色青，则为阴寒之证矣。总之，白为气虚之象，纵有失血发热，皆为虚火，断无实热之理。

黑色属肾，主痛主寒。焦黑阳热，青黑阴寒。面黑肥泽，筋骨必强；面黑瘦削，阴火内戕。面色黧黑，病多中恶；乌痧胀者，面赤黧黑。天庭黯黑，脑髓枯竭；承浆青黑，手足抽掣。总而言之，五色之中，青黑黯惨，真脏色现，凡病新久，皆属危险。

[参] 面黑光润，其貌魁伟，时人谓之黑相，多属下焦气旺。虽犯客寒，亦多蕴为邪热，绝少虚寒之候。惟面色黯惨，无论病之新久，皆属阳气不振。若面黑色夭，此谓脑髓死色。故《内经》谓黑色若见于天庭，大如拇指，必不病而卒死。总之，黑为阴晦之色，加于头面之阳位，或面唇青黑，或五官忽起黑色，其病皆多凶少吉。

以上概言通面之色，面为足阳明胃经所主，凡五脏之气，皆禀于胃，则五脏之色，亦必由胃气所蒸，上荣于面，此《内经》所谓五色微诊，可以目察，能合色脉，可以万全，以阐儿科四时百病五色生死之诊法也。

丁、面分五部总诀

察儿面色，宜分部位，左颊属肝，右颊属肺，心额肾颐，惟鼻主脾。

[参]《内经》曰：左右者，阴阳之道路也。阳从左升，阴从右降，故以左颊配肝，右颊配肺。额曰天庭，天庭高，主离阳心火。颐曰地角，地角低，主坎阴肾水。上下分配，亦阳上阴下之义也。《内经》以鼻为面王，以其位居至中，内通呼吸，生死赖之，脾主中焦，故经主鼻准候脾，此钱氏遵《内经》分部乃儿科简要之诊法也。惟《灵枢》谓庭（即天庭）以候首面，阙（即眉心）以候肺，阙上以候咽喉，下极（即山根）以候心，年寿（即鼻柱）以候肝，其左右以候胆，面王（即鼻准）以候脾，方上（即鼻坠）以候胃，人中以候膀胱子宫，面中央（颧骨之下迎香之外）以候大肠，大肠之旁（颊之上也）以候肾。面王以上（两颧内鼻准旁）以候小肠。此较前五部诊法，尤为详明，精研儿科学者，临证时不可不参用也。

戊、面上五部热病

肝热病者，左颊先赤；心热病者，其颜先赤；脾热病者，其鼻先赤；肺热病者，右颊先赤；肾热病者，其颐先赤。病虽未发，见赤色者，皆属伏热，即刺而泄。

[参]此以上下左右中之部位，分属五脏，为察色辨症之法。故钱氏《直诀》云：左腮为肝，右腮为肺，额上为心，鼻为脾，颊为肾，赤者热也，随证治之。

按：额上曰颜，腮为面颊，颐下为颊。《直诀》与经旨，词虽异而义则同，总以遵经旨为有本。前清章虚谷注《内经》伏气温热篇云：此详五脏热邪未发，而必先见于色之可辨也。左颊颜鼻右颊颐，是肝心脾肺肾脏之气，应于面之部位也。病虽未发，其色先见，可见邪本伏于血气之中，随气血流行而不觉。更可印证《难经》所云：温病之脉，行在诸经，不知何经之动也，故其发也，必随生气而动，动则先现色于面，良工望而知其邪动之处，乘其始动，即刺而泄之，使邪势杀而病自轻。即《难经》所云：随其经之所在而取之者，是为上工治未病也。用药之法，亦可类推矣。

此条家严悉本经文，编为韵语，与钱氏《直诀》，先后一揆，足见小儿病多伏热。热盛动风，症多发搐，《伤寒论》所谓风温之为病，剧则如惊痫，时时瘈瘲是也。后世儿科，但知因惊发搐，混称曰惊风，杜撰许多惊名，乱推乱挑，误杀乳婴，不可胜数。皆由病因不明，诊断不精，不知伏热为病，误认为惊者阶之厉也。叶天士云：小儿热病最多者，以体属纯阳，六气著人，气血皆化为热也。饮食不化，蕴蒸于里，亦从热化矣。旨哉言乎！

己、面诊五部形色要诀

额虽属心，上通前脑，神经攸关，诊毋轻藐。太阳日角，方广天庭，小卤印堂，皆属脑心。天庭色盛，脑气旺极；天庭色衰，脑髓虚竭；天庭色萎，有皱纹者，症必难治。日月角陷，已失色者，必死不治。青遮日

角，凶陷者绝；黑掩太阳，额冷者脱。小凶先赤，后印堂青，心火生风，非惊则痉；小凶先青，后印堂赤，肝火冲心，必痉而厥。方广光滑，病机多吉；方广昏暗，症势必剧。天庭晦黑，顺症须防，若病险逆，一见即亡。

[参] 额者，发际下两眉上之部位也。属前头部，为前脑知觉神经之总机关也。故头为精明之府，精明在脑也。脑为髓之海，凡儿天禀充足，髓海有余者，头角丰隆，额绽色亮，病虽重，每可救疗。素禀虚怯，髓海不足者，面白颅解，发稀色夭，病虽轻，必多猝变。望其色，最喜红光，切忌青黑。若白若黄，又其次也。临症诊法，如蒋仲芳验色歌诀，一云：额间赤色心经热，烦躁惊悸不必说，青黑腹疼又惊风，痲痲叫啼何时歇，微黄惊疳自古传，纯黑之时命已绝。二云：左右两额称太阳，太阳青时二次惊，青自太阳入耳死，红色见时主血淋。皆为实验心得之要诀。

颊下名腮，腮为面颊，左肝右肺，色呈两颊。左颊青赤，肝风心热；青紫似黑，腹疼惊厥。右颊深赤，风温肺热；青暗带黑，腹疼筋急。左颊鲜红，肝有风热；右颊鲜红，肺受火劫。两颊皆青，客忤猝惊；两颊均赤，火风发痉。

[参] 颊在面旁，俗称嘴巴，其病之发现于色也。如蒋氏歌诀，一云：左颊青赤肝风热，项脊牵强病之诀，惊痉腹痛定黑青，细心推看心能诀。二云：风邪发热右颊赤，咳嗽便闭并气急，青白恶心或咳嗽，青黑内吊腹疼极。三云：客忤之病两颊青，食痰喘急黄色亲，

红主风热须凉散，两颊赤时伤寒寻。皆为临症实验之薪传。

鼻梁鼻准，皆在面中，内关脾胃，中气之宗。鼻梁色青，为寒为痛；鼻梁色赤，为热为风。鼻梁色黄，痰饮湿热；鼻梁色白，气虚亡血。鼻梁深赤，脾胃实热；鼻梁微赤，脾经虚热。鼻准红燥，暴病脾热；鼻准惨黄，久病脾泄。年寿赤光，多生脓血；山根青黑，须防惊厥。

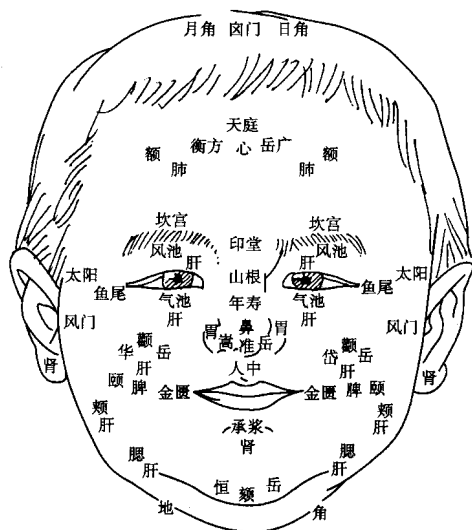
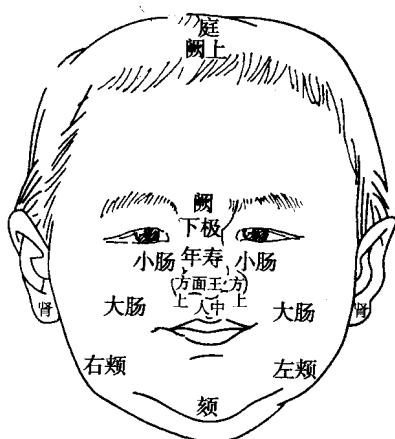
[参]《灵枢》曰：明堂者鼻也。明堂广大者寿，小者殆。若明堂虽小，与面部相称者亦寿。和田东郭曰：诊大病，鼻梁亦为要诀，其病之现于鼻色也。如蒋氏验色歌诀，一云：脾胃热极鼻色赤，小便不通深黄色，鼻中干燥及气粗，衄血之症因而得，脾虚泄泻若何形，乳食不化鼻淡白，脾经受寒色白青，黑为死候君须识。二云：二次受惊山根青，山根黑黄死来侵，年寿平陷亦主夭，青色发热更生惊，黑主泻痢红主燥，微黄隐隐始为平。皆为临症实验之要诀。他如推拿专科周于番曰：鼻上汗出如雨者，心胃病。鼻色鲜红者，留饮；紫暗者，时病。鼻色青主吐乳，又主腹中痛，肢冷者死。鼻痛者为风火。鼻色黄黑而亮者，小腹两胁痛及蓄血。鼻尖青黄色者为淋。若病人鼻尖山根明亮，目眦黄者，病欲愈。皆其历验之心得也。

额上曰颞，颞下曰颞，人中承浆，皆其所赅。《内经》《直诀》，虽皆属肾，然与脾胃，形色并呈。肾热病者，颞多先赤；胃火盛者，颞亦肿赤。颞间深赤，肾膀胱热结；颞间微赤，肾膀胱湿热。脾冷滞颞，颞多青白；胃

热吐虫，颐多青赤。人中黄者，伤乳吐逆；人中青者，下痢积热。承浆青者，食时被惊；承浆黑者，惊厥发痉。

[参] 颐在口角之后，腮之下，属肾。颊在颌之下，结喉之上，两旁虚软无骨处也（颌者含也，面部下端生须处，与上腭相合，可以含物也）。人中者，鼻准之下，口唇之上，在鼻与口中间之部位也。承浆者，口唇之下，颊之上，居中之部位也。颐与颊虽皆属肾，而与消化器有密切之关系，故曰颐，养也，谓下动上静，咀嚼以养人也。所以滞颐属脾冷流涎，发颐主胃火毒盛。其病色之发现也，如蒋氏验色歌诀，一云：小便不通颊间赤，肾与膀胱皆热结，两颐青时主吐虫，古人望色从来的。二云：伤乳胃逆人中黄，青主下痢乳食妨，嗳气酸腐食不进，黑色虫痛定须防。三云：食时被惊承浆青，黄主吐逆血病因，黑色惊风须急救，颊长肾足寿元形。皆为实地经验之要诀。总之，面部五色，黄赤为阳，故为病主风主热；青白黑为阴，故为病主寒主痛。皤白者，浅淡白色也，主失血。否则心不生血，故其色不荣。微黑者，浅淡黑色，肾病水寒也。萎黄者，浅淡黄色，诸虚见症也，此为察色辨证之纲要。清余梦塘曰：面色通红为心热，面色全青为肝风，面色通黄为脾伤，面色皤白为肺脏虚寒，面色黧黑为肾脏馁败。其言如此，似未免拘于五脏五色之说。按：面为足阳明胃经所主，亦载《内经》，然则通面之色，未尝不有关于胃经。又谓髓海不足者色夭，则脑亦于面有关。由是推之，面色显明，新病而实者，多属于胃；面色晦黯，久病而虚

者，多属于脑。且小儿质性不同，各如其面，金水之质，其人肥白，多属气虚，面色每多惨淡；木火之质，其人苍瘦，多属血虚，面色每多红燥。此亦望面色之要义也。虽然吾侪从实地上经验，望色断症之法，有时可



据，亦有时不可据。尤必察明原因，详审苗窍，细观指纹，静验见症，兼察声音，操斯术也以治婴儿。书云：如保赤子，心诚求之。庶可幼吾幼以及人之幼，而免学医人废之讥矣。

第四节 望苗窍形色

欲知肝病，先察目中。脾唇心舌，窍自相通。肺有病时，须观鼻孔。两耳属肾，五窍皆重。别有二阴，下窍之宗。察色辨症，诀亦相同。

[参]《内经》谓东方青色，入通于肝，开窍于目，旺于春。南方赤色，入通于心，开窍于耳，其华舌，旺于夏。中央黄色，入通于脾，开窍于口，旺于长夏及四季之末。西方白色，入通于肺，开窍于鼻，旺于秋。北方黑色，入通于肾，开窍于二阴，上通于耳，其旺冬。观此，以七窍辨内脏之症候，虽为儿科名医所阐发，其实皆折衷经旨。惟面上官能，亦皆关于脑神经。如耳为司听之官，由其中鼓膜受空气之振动，传达于听神经，而知外部之音响也。目为视官，其内部之构造，略如照相器械，有凸面之水晶体，以摄物影而达于瞳孔后之网脉，经视神经而传于大脑，乃生视觉。鼻为司嗅之官，外状为隆起之三角形，内部为筋肉及软硬二骨所成，其腔分三道，前通鼻之两孔，后连咽头，腔内有黏膜，密布嗅神经，用以识别香臭。而呼吸空气，尤利赖之。口为进饮食发声音之官，位置于头部之下方，内含有味神经。凡人藉口以发言，故多以为言之代词。舌为司味之

官，在口中为筋纤维所成，能自由运动，表面包以黏膜，神经血管布满其中，感觉最敏锐处也，亦以为发音之助。由是推之，凡病因之外感内伤，病机之寒热虚实，其五色之见于苗窍，虽皆由内脏血色素之发现，而其所以有知觉，所以能运动者，皆关于脑神经之作用。西医生理学云，脑心肺为人身三大要经，洵不诬也。前明万密斋云：肝之病见于目，心之病见于舌，脾之病见于唇，肺之病见于鼻，肾之病见于耳，各随其寒热虚实决之。前清夏禹铸曰：五脏不可望，惟望五脏之苗与窍，其色若异于平日，而苗窍之色，与面色相符，则脏腑虚实，无有不验者矣。惟肾开窍于二阴，职司二便，合之则成为七窍。前清张筱衫曰：溲由前阴出，便由后阴出，寒自寒，热自热，以此区辨形色，则外感内伤之真寒假热、真热假寒，临症时自能立判矣。

甲、察两耳形色要诀

耳为肾窍，上通于脑，肺心肝胆，皆由斯道。耳轮红润，肾经充足；耳珠青黑，肾阴枯涸。耳起青筋，风温痙痙；耳发红肿，胆火暴聋。外染风毒，耳黄面热；上受风热，耳红面赤。耳尖青冷，主发痘疹；耳筋紫黑，多属凶症。耳前色黑，主疔主痛；耳前色青，为燥为风。

耳痿失色，肾绝不治；耳枯色垢，肾败难治。

[参] 耳珠属肾，耳轮属脾，耳上轮属心，耳皮肉属肺，耳背玉楼属肝。上中下分配五脏，邵氏《痘证大全》称为秘法，一则云：耳上属心，凡出痘时，宜色红而热。若色黑与白而冷，其筋纹如梅花品字样，或串字

样，从耳皮上出者，皆逆者。二则云：耳下属肾，凡出痘时，其色宜红紫带冷，不宜淡黄壮热。如筋纹梅花品字样为顺，若如蚤咬芝麻之形者，为险逆难治之候。三则云：耳后耳里属肺，凡出痘时，其色宜淡白带温，不宜红紫壮热。如见茱萸形，或灯火烧烙之样，为逆。四则云：耳后耳外属肝，凡出痘时，其色宜青带温，不宜淡白冰冷。稀疏者吉，稠密者凶。五则云：耳后中间属脾，凡出痘时，宜苍黄温和，不宜青色壮热。稀疏如黄蜡色者吉，稠密如蚁色带青者凶。六则云：凡出痘耳后筋三条，而枝叶多色淡红者吉，系心经发痘，主头面稀少。七则云：凡出痘耳后筋紫赤色者，主肝经发痘，而急出者凶。八则云：凡出痘耳后筋苍黄色者，或筋头大而根转小，系脾经发痘，主头面胸腹必稀。九则云：凡出痘耳后筋淡而色白者，枝叶繁乱，系肺经发痘，出如蚕种，主痒塌极凶之兆，三五日必亡。十则云：凡出痘耳筋色黑，枝叶多者，系肾经发痘，主黑陷伏毒，九朝十朝内必死。十一则云：凡发热耳筋出现紫黑赤白，皆凶。耳上凉者吉，耳下凉者凶。故凡看小儿潮热之际，以两耳辨其五色为验，便知生死轻重之分矣。其言如此，惟耳虽为肾窍，而五脏所结，系于耳者居多。症属外感，其形则或冷或热；病属内伤，其色则或暗或滞。善观两耳形色者，可察各症之寒热虚实。若徒取以辨痘证，则拘矣。蒋氏验色主病歌诀云：



耳后微赤虚鸣证，本经受热宜知悉，耳轮干燥是骨蒸，口渴盗汗肝热盛。其明证也。

乙、察两目形色要诀

目为肝窍，系通于脑，五脏精华，上注斯道。白珠属肺，内关心脾，若见青色，肝风乘肺。目白而混，肺经实热；目白而淡，肺经虚热。目白鲜红，心经实热；目白淡红，心经虚热。目白深黄，脾经实热；目白微黄，脾经虚热。目白老黄，脾胃湿热；目白暗黄，脾胃瘀热。目白深青，肝经实热；目白淡青，肝经虚热，黑珠属肝，主眇主泪。黑光满轮，主寿易养；黑色昏矇，多夭难养。黑多白少，肝血充足；黑少白多，肝阴不足。肝气实者，眇多干坚；肝气虚者，眇淡胶黏。寒伤肝者，迎风泪流；热伤肝者，眇泪交流。哭而无泪，不哭泪出，目开不合，皆为肝绝。瞳仁属肾，贵有精神。赤脉贯瞳，火烁肾阴；白膜遮精，肾疳已成。目睛稍定，忽转动者，多属痰证。目瞪睛定，不转动者，皆属绝症。斜视转睛，肝风热痉；闭目露睛，慢脾虚痉。目睛不和，昏神热极；目睛不明，神散精竭。凡儿发搐，目睛斜视，属男孩者，左视无声，右视有声；属女婴者，右视无声，左视有声。瞳仁缩小，脑髓枯结；瞳仁放大，元神将脱。目睛正圆，病决不治；目睛直视，断难救治。眼角红丝，穿入白珠，心火冲肺，有实有虚。鲜红属实，淡红属虚。大眼角红，肿痛实热；小角淡红，微痛虚热。大角破烂，心经血热；小角破烂，肺伤风热。上胞属脾，肿则湿热；下胞属胃，青则风热；上下胞肿，脾胃风热。胞缩露睛，脾胃虚极。眼睑烂赤，

多由风湿。风胜则痒，湿胜则烂。目上紫筋，目下青筋，二筋若现，必发惊痉。

〔参〕《内经》谓五脏六腑之精华皆上注于目，故眼科学五轮定法。白珠属肺，为气轮；黑珠属肝，为风轮；瞳仁属肾，为水轮；大小眼眦属心，为血轮；上下眼胞属脾胃，为肉轮。惟目系则上入于脑，脑为髓海，髓之精为瞳子（即瞳神），为脑中元神出入之门户。按：目系即视神经，别有反动性，能感触光线，收缩瞳孔，约有四对。①动眼神经，出蝴蝶骨之裂孔，分布动眼筋，主宰眼球之运动，司眼睑牵动筋及瞳孔括约筋之运动，亦曰运动神经，传神经中枢之命令于诸部者也。②滑车神经，亦出蝴蝶骨之裂孔，分布上斜眼筋，主宰眼珠之运动，司眼球向外之运动。③三叉神经，区分三支，第一支，分布颜面眼球与鼻；第二支，分布上腭与齿髓；第三支，分布下腭与口壁，以司味觉。生成感觉运动二纤维，大者司角膜眼结膜之感觉，小者司瞳孔咀嚼筋之运动。④牵引神经，出颈动脉小孔，分布眼球之外直筋，即主宰眼球之运动。若麻木则眼球内斜视矣。两目之贵重如此，故经曰视其目色，以知病之存亡也。若肝开窍于目者，因肝脉交巅络脑，与脑髓神经有密切之关系者也。其为病也，蒋氏验色主病歌诀云：两眼黑睛黄主热，白睛黄时食积诀（主疳病及黄疸），白睛青时主惊痉，黑睛红黄伤寒劫。凡目直视，目斜视，目连割，目淡青或赤，皆肝病犯脑之特征。目睛视物不转，或目合不开，或目开不合，或哭而无泪，或不哭而泪出，皆肝病连脑之绝证。总之，目明能识人者易治，目

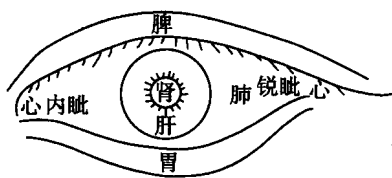
昏不识人者难治。身体发热而眼羞明者，其病必重。瞳孔过小而且斜视者，其病最重。若目反上视，或目瞪不轮，或目睛正圆，或戴眼反折，或眼胞陷下者，皆必死不治也。婴儿颅囟未合，脑髓最灵，视神经最易感触，不论外感内伤，一动肝风；无不刺激神经，或为脑膜炎，或为脊髓脑膜炎，所以婴儿多痉与痙痲之证也。此为望色审窍之第一要诀，研究儿科学者，首宜识此。

丙、察鼻孔形色要诀

鼻孔属肺，吸收空气，窍虽司臭，呼吸尤利。流清涕者，风寒袭肺；流浊涕者，风热犯肺。鼻孔液干，秋燥伤肺；鼻孔气臭，内痈伤肺。鼻孔癰胀，肺热有风；鼻孔扇张，肺痰上壅。初病鼻扇，咳喘肺室；久病鼻扇，喘汗肺绝。鼻涕常流，初病鼻渊，鼻涕浊秽，久病鼻渊。鼻孔燥黑，如烟煤者，阳毒热极；鼻孔黑润，出冷气者，阴毒冷极。

23

〔参〕鼻为司臭之窍，全在左右二孔，孔内有黏膜，有毫毛，凡物质之气，由空气传达于此，即能识别香臭，而呼吸尤利



赖之。故《灵枢经》曰：肺气通于鼻，肺和则鼻能知香臭矣。其为病也，鼻伤风，则鼻塞喷嚏，鼻流清涕；鼻伤热，则鼻门干燥，甚或鼻衄，或燥破生疮。鼻鼾难言者风温，鼻鸣干燥者风热。鼻孔扇张，出气多，人气少者，无论外感内伤，症多不治。然有虚实新久之分，不

可概言肺绝。若初病即鼻扇，多由邪热风火，挟痰壅塞肺气使然；若久病鼻扇喘汗者，则为肺绝不治。

丁、察口唇齿形色要诀

口为脾窍，实关于胃，其华在唇，齿络肠胃，为肾之余。诊法一揆，先看口唇。口中气热，从外生风；口中气温，从内生风。口鼻气粗，疾出疾入，邪气有余，外感实症；口鼻气微，徐出徐入，正气不足，内伤虚症。口干舌燥，胃心皆热；口燥咽痛，胃肾并热。口燥咬牙，热盛风痉；口噤鼻扇，痰厥急惊。口吐粘涎，脾热实症；口流稀涎，脾冷虚症。口张大开，症属脾绝；口出鸦声，症属肺绝。口如鱼嘴，口气直喷，皆属绝症。环口黧黑，口燥齿枯，皆为死症。口齿糜腐，则为口疳；口鼻生疮，则为肺疳。唇焦而红，少凶多吉；唇焦而黑，多凶少吉。唇干而焦，脾蕴燥热；唇淡而黄，脾积湿热。唇燥舌干，心脾热极；唇肿舌焦，脾胃热极。口唇红紫，血瘀虫啮；口唇淡白，营虚失血。唇红吐血，胃热盛极；唇白吐涎，脾冷虚极。唇赤如朱，心经血热，唇白如雪，脾阳将绝。唇茧舌裂，多属毒积；唇紫声哑，多属虫积。上唇有疮（唇有白点），虫食其脏；下唇有疮，虫食其肛。唇蹇而缩，不能盖齿，固属脾绝。唇卷而反，兼舌短者，亦属脾绝。唇口颤摇，不止者死。唇吻反青，气冷亦死。次观其齿，齿燥无津，胃实热极；齿焦而枯，胃液涸竭。咬牙齬齿，口筋牵掣；但咬不齬，牙关紧急。上齿龈燥，胃络热极；下齿龈燥，肠络热极。齿光如石，胃热甚剧；齿如枯骨，肾

阴已竭。齿燥如糕，胃肾两竭，齿忽啮人，心肾气绝。热耗胃津，齿色必紫，紫如干漆，尚可挽回；热耗肾液，齿色必黄，黄如酱瓣，其症多危。齿缝流血，若牙痛者，胃火冲激；血出牙龈，若不痛者，肾火上逼。

[参] 口为司言食之窍；在面部下方。口窍之边曰唇，唇内有齿，齿内有舌，食物皆由此入内，以营养身体。故《内经》曰：口唇者，声音之扇。《难经》曰：口唇者，肌肉之本。经又谓脾胃之华在唇四白，四白者，唇之四际白肉也，与肺最相关系。盖呼气从口而出，吸气从鼻而入，故足太阴脾与手太阴肺，同为一经。然口主饮食，无不先通于胃，而口内廉泉玉英二穴，由足少阴肾化气上行，以生津液，故《内经》谓津液之道。经又云：女子七岁肾气盛，齿更，三七肾气平均，故真牙生而长极。男子八岁肾气实，齿更，三八真牙生，五八齿槁，八八则齿发去。若上齿龈，为足阳明胃络，下齿龈，为手阳明大肠络，亦载《内经》。故唇齿相依，为口出声调语纳食咯痰之机关，而与肺脾肾胃肠，各有相维相系之处。虚实寒热从此分，生死亦从此决。其为病也，口甜，是肝热脾湿，胃有痰滞也。口咸，是肾水上泛，肾热也。口淡口臭，皆胃热也。口辛，肺热也。口苦，胆热也。口酸，肝热也。若口如鱼嘴尖起者，为鱼口，则啼不出声，或音如鸦声，皆脾败肺绝之候也。唇属脾，红紫血热也；淡白气虚也；青黑者肝乘脾，脾阳将绝也。亦关于胃，唇红而吐，胃热也；唇白而吐，胃虚也；唇色平常而吐，作伤胃论。凡儿病人中平满，为唇反，唇反者肉先死，俱不治。齿为肾之余，龈为胃之络，前板齿燥，脉虚者，多中暑；下截齿燥，脉扎

者，多便血。惟齿槁者多属肾热。总之，口唇齿三者，皆为消化器之重要部分，细察形色，于诊断上亦最有验。

第五节 验舌苔形色要诀

舌为心苗，膜接胃肠，脾肾肝脑，辨别宜详。舌尖属心，故主上焦，舌中脾胃，故主中焦；舌根属肾，故主下焦。舌上乳头，辨味之应，内含血管，密布神经。验舌之要，先观其舌，次察其苔，乃能确实。

[参] 舌在口腔之中，系赤色筋肉，纵长横狭，前尖后大，表面凹凸不平。其突高处，多成细点，在舌心者，形如蕈菌，点旁附有小物，形如花蕾；在舌根者，形如小豆，其数由八颗至十颗，常作人字形排列。舌之表面，皆有黏膜盖之，内应心脏，外司味觉。咸苦两味，舌心最易感触；甘酸两味，舌边最易感触。其所以最易感触者，在于舌乳头及舌神经。舌乳头者，即舌上小粒突起之处，内含血管，及与脑相连之味神经，以辨食味。共有三种，一丝状乳头，在舌旁及舌面，其上面有丝形突起之线。二蕈状乳头，散在丝状乳头之间，于舌尖为最多。三轮廓乳头，在舌根近旁，排列如人字形，较前数种为大，内藏味神经之末梢，曰味蕾。舌神经者，即分布于舌上之脑气筋也，上连于脑，有味神经及动舌神经之别，以司辨味及运动舌体之用。此言舌生理上之体用也，更论舌与内脏经脉气化之关系，及其病理。《内经》云：舌者，心之官也。心主言，在窍为舌。手少阴之别，系舌本。手少阴之筋，支者，系舌本。心

气通于舌，心和则舌能知五味也。其为病也，心病，则舌卷短，颧赤，心脉搏坚而长，当病舌卷不能言，且其实则支膈，虚则不能言。经又云：足少阴循喉咙，挟舌本，至任脉廉泉穴而终。足少阴之脉，贯肾，系舌本，足之少阴，上系于舌，终于横骨，终于会厌。足少阴之标，在背腧与舌下两脉也。舌下两脉者，廉泉玉英也。廉泉玉英者，津液之道也。其为病也，舌纵，则涎下烦惋，取足少阴。肾所生病者，口热舌干，咽肿上气，嗑干及痛，烦心心痛，刺足少阴脉，重虚出血，为舌难以言。又云：足太阴之正，上至髀，合于阴阳，与别俱行，上结于咽，贯舌中，足太阴之标，在背腧与舌本也。脾足太阴之脉，上膈挟咽，连舌本，散舌下。其为病也，舌本强，或舌本痛，食则呕，胃脘痛，腹胀善噫，得后与气，则快然如衰，身体皆重，刺舌下中脉，太过血出不止，为瘡。又云：上焦出于胃上口，并咽以上，贯膈而布胸中，走腋，循太阴之分而行，还至阳明，上至舌下。足阳明，其浊气出于胃，走唇舌而为味。又云：足厥阴气绝，则筋绝。厥阴者肝脉也，肝者筋之合也。筋者，聚于阴器而脉络于舌本也。故脉不荣则筋急，筋急则引舌与卵。故唇青舌卷卵缩，则筋先死。庚笃辛死，厥阴终者，中热咽干，善溺心烦，则舌卷而卵上缩而终矣。他如足太阳之筋，其支者，别入结于舌本。手少阳之筋，其支者，当曲颊入系舌本，其病舌卷，亦载《内经》。至若舌苔，舌上所生之垢腻也。外感病在表时，往往无苔，迨渐入于里，与津液相搏，则舌上之垢腻渐多。有白苔舌、黄苔舌、黑苔舌、灰苔

舌、霉酱黑苔舌、红色舌、紫色舌、青色舌八种。前清梁特岩曰：舌居肺上，腠理与肠胃相连，腹中邪气，熏蒸酝酿，亲切显露，有病与否，昭然若揭，亦确然可恃。故凡辨舌，无苔，则审舌之本色；有苔，则凭舌之现色。参之望闻问切，以判表里寒热虚实之真假，虽不中不远矣。西医柯为良曰：凡舌上面有刺，刺中有脑芯，能主尝味，亦有苔，用以察病，最为有益。西医合信氏曰：验舌苔形色干湿，可辨表里。合古今中外学说以参观之，验舌为诊断上之最要。中西一致，特西医察舌，不若中医之精且细耳。

凡验舌苔，婴孩小童，各宜区别，观察不同。婴儿之舌，本有乳苔，白滑而薄，是为常苔。一有感伤，形色随变，胎毒遗传，必先明辨。

舌难转动，肿硬苔白，不能吮乳，此为木舌。舌色鲜红，下生小舌，位近舌根，此为重舌。舌根生泡，状若白珠，啼而不乳，俗称顶珠。舌生白屑，黏潺满口，吮乳不得，俗称鹅口。视此四症，婴儿所独，或由胎热，或因胎毒。

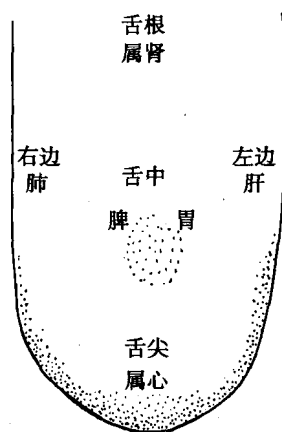
[参] 凡小儿三四岁以下，患感症杂病，辨舌与少壮略同。惟产生至一二岁，其舌有特种疾患，不可不防之。美医嘉约翰云：小儿之病，舌上每有白衣，若初生小儿，舌上白膜裹住，或如石榴子，或遍舌根，哭不出声，若不刮去，其儿必哑，或发惊。若小儿舌根下，忽有筋一条，绊其舌尖，不能吮乳，或舌下总筋，上生白膜，连舌尖绊住，用银针磨尖，轻轻挑断之。若初生儿，舌上忽生黄泡出水，此为心脾之火。若小儿初生，

舌上生白屑如米，剧者口鼻亦有之，此由胞胎中受谷气盛，所谓鹅口是也。凡小儿舌大肿硬，不能转动，此心火挟痰也，通称木舌。若舌肿满口，或胀出口外，难纳药者，所谓肿舌是也。此皆小儿所特有者也。

若验舌苔，多由胃浊。苔厚而多，胃有腐浊；苔薄而少，胃鲜腐浊。鲜红实热，淡红虚热，深红血热，暗红瘀热，淡白虚寒，滑白痰积，白腻湿滞，黄腻湿热。白腻而厚，胃肠冷积；黄厚而糙，胃肠热积。舌红而肿，胎热盛极；舌紫且黑，胎毒发泄。舌现白点，连唇亦生，或起槟纹，虫积特征。舌色红紫，疼痛异常，甚则红烂，舌疳凶状。

[参] 清刘吉人云：舌为胃之外候，以助输送食物，入食管胃脘之用。其舌体之组织系由第五对脑筋达舌，其功用全赖此筋运动。舌下有青紫筋二条，乃下焦肾脉上达。有穴二，名曰金津、玉液，所以生津液以濡舌质拌化食物者也。舌之表面，乃多数极小乳头铺合而成，此乳头极小微点，以显微镜窥之，则时见形如芒刺，摸之棘手，或隐或现，或大或小，或平滑，或高起，随时随症，变易不定。中医以舌苔辨症者，苔即胃中食物腐化之浊气，堆于乳头之上，此明舌苔之所由生也。常人一日三餐，故苔日亦三变，谓之活苔，无病之象也。其所以能变者，因饮食入胃时，将腐浊遏郁下降，故苔色一退，至饮食腐化，浊气上蒸，苔色又生。胃中无腐浊，则苔薄而少，有腐浊则苔厚而多，此其常理也。若辨苔色之法，白而薄者，寒邪在表，或气郁不舒；白而厚者，中脘素寒，或湿痰不化。黄苔薄而化者，表犹未

罢，热未伤津。黄苔有质地而浊者，邪已结里。若黄浊愈甚；则入里愈深，热邪愈结。黑苔焦枯，为火炽水竭。久病舌起烟煤者，属胃虚液涸。又如苔色淡白者，多寒有水；及发纹满布者多湿。其色黄厚者，多食滞；带灰及干砂刺点者；多伏热。色见黄白，间或焦黑者，气分化燥；舌色绛红，间或光亮者，血分受热。平日多



黄苔，其人必胃热；多红色，其人必营虚。至于如水黑青色者为虚寒，如咸腻厚者为温疫，此皆朱心农临症实验之看法。西医嘉约翰云：凡各种重病，舌皆有苔，伤风发热病第一层时，喉核生炎，舌上有一层白蜜色之苔。发热病第二层，舌有厚黄色或黑色之苔。若胃肠中有燥粪，胆汁则逆流而上，其色即黄。苔色黑者，表明血中有碳气，为有毒也。血不清洁，生津不爽，并大便恶臭之时，舌有一层厚黑干苔，牙有黑垢。舌有紫色干苔，惹厌□之病将退，舌即渐变湿润。黄疸病，舌有胆

汁色之苔。身虚泄血病，舌有湿苔。好饮酒，其舌上常有裂纹，则舌体多紫。此皆验舌苔之大要也。

第六节 察溲便形色要诀

前后二阴，为肾之窍。前为清窍，后为浊窍。溲出前阴，便出后阴，二便形色，可断病情。溲名水液，载在《内经》。澄沏清冷，皆属寒证；浑浊臊臭，皆属热证。溲如米泔，则为湿热；溲如苏木，则为血热。红黄色者，肝经实热；淡黄色者，肾经虚热。睡中遗溺，谓之尿床。溲凝如膏，溺白之状。溺长清利，肾气充极；溺短涩痛，膀胱热结。溺时点滴，尿管痛剧，沙淋之候。溺如米浆，混浊滑流，溺浊之候。便色老黄，则为实热；便色淡黄，则为虚热。便如桃浆，则为血热；便如胶漆，则为瘀热。大便腥臭，如败卵者，内伤乳积；大便酸臭，如坏醋者，内伤食积。大便急迫，肠鸣腹痛，为小肠热；大便灼痛，肛热如焚，为直肠热。

31

〔参〕肾有内外之别，内肾俗称腰子，为分析血中废料，盛尿液之器官。在腹腔之背，共二枚，对列于左右。形如蚕豆，色红褐，外旁凸出，内旁凹入，凹入处，曰肾门。全体分肾皮、肾髓、肾盂、肾圆锥、谋氏囊、输尿管各部。肾门间，有肾动脉及肾静脉各一，血液由肾动脉入肾中谋氏囊及输尿管，滤取尿液。尿液入肾圆锥，经肾盂及输尿管入膀胱。余血则从输尿管出而入肾静脉，复归心脏。膀胱俗称尿泡，为贮尿之囊，作卵圆形，颇有弹性，在腹腔下部，其底旁左右，各有输

尿管一条，通于肾脏，前面下旁，又有排尿口，口有括约肌与尿道连接，肾脏分泌之尿，经输尿管入于膀胱，贮蓄既满，则放开括约筋，从尿道泄出，故肾与膀胱为泌尿之器。观此，则《内经》所云肾与膀胱相表里，主水，为胃之关，关门不利，故聚水而从其类焉；膀胱者，州都之官，津液藏焉（津液即尿液），气化则能出矣者，则中西一致矣。大肠，即肠之下部，形如管，较小肠为粗短，上接小肠，下连肛门，分盲肠、结肠、直肠三部，盘曲于腹内，内面之黏膜无绒毛，不能如小肠之善吸养料，但能吸收水汁，使废物为粪块而出。故《内经》所云大肠者，传导之官，化物出焉者，亦新旧沟通矣。其为病也，如《内经》云：中气不足，溲便为之变。变也者，如中气不足以御寒，溲则澄沏清冷，甚则膀胱不约而遗溺，便则溏泻飧泄，甚则大小肠直倾而洞泄。中气不足以制热，溲则水液浑浊，甚则膀胱不利为癃，便则胶闭燥结，甚则大小肠胶结而为痢，此皆有形色之可辨也。若询之疑似，则令病家取至庭中，观其形，望其色，藉以审疑难大症，初不可嫌其秽褻，庶免讹传误听之弊，以此区辨，则寒热虚实立判矣。

第七节 望指纹形色

幼科指纹，聚讼纷纷，推原其理，学本经文。

[参]《灵枢经》云：经脉者，常不可见也，其虚实也，以气口知之。脉之见者，皆络脉也。凡诊络脉，色青则寒且痛；赤则有热。胃中寒，鱼际络多青；胃中热，

鱼际络红。其暴黑者，留久痹也。其有赤、有黑、有青者，寒热气也。其青短者，少气也。诊虎口指纹之说，盖本乎此。陈飞霞谓《内经》十二经络，始于手太阴，其支者，从手腕后出食指之端，而交通荣卫于手阳明大肠之经，即此指纹是也。由是推之，以经解经，《内经》所谓其支者，即太渊脉之旁支，亦即与手臂脉并行之鱼际络也。陈氏谓此脉可诊，其迟数代促，与太渊脉毫无差异，此说不确。盖经是动脉，络是静脉，动脉有脉波可诊，静脉无脉波，焉有迟数代促之可辨乎？又谓指纹之法，起于宋人钱仲阳，尤属杜撰。检阅钱氏《小儿药证直诀》，无此语也。张景岳谓此纹为手阳明浮络，络则是矣，非手阳明也。《内经》明言胃中寒鱼际络青，胃中热鱼际络红，其为足阳明之浮络也明矣。就余所验，风寒初起，色多浮而淡青，郁而化热，轻则其色鲜红，重则其色紫黑。若胃热盛而动肝风者，往往其色青紫。位则自下而上，邪则自浅而深，症则自轻而重，皆由历验之成绩。原其辨指纹之法，起于宋人《水镜诀》，创立风气命三关。关即指节也。风气命三字，即虎口至次指上中下三节之代名词也。宋以后幼科诸书，均未推原其故，惟滑伯仁谓纹见下节风关为轻，纹见中节气关为重，纹见上节命关为危，直透三关为大危。以络脉所现之短长，审病势之浅深，固属法程。夏禹铸以络脉之浮沉，辨病状之表里，亦有理由。此皆言指纹之形也，若论纹色，但当以青紫分寒热，红黑辨吉凶，淡滞定虚实，可为诊断之一助。他如幼科书有云，指上辨青纹，认是四足惊，虎口脉青色，是猪犬马惊，黑色因水扑，即色火人惊，

紫色多成泻，黄即是雷惊。又曰，青惊白是疳，黄即困脾端；青色大小曲，人惊并四足云云，则荒诞不经矣。石芾庭曰：儿病传变不常，即《内经》以色诊络之说，亦不可拘，惟手络不宜暴露，是为要诀，以过露为血燥生风候也。可谓阅历有得之名言矣。指纹之说，虽历代相传，但不过望色中之一种耳。兹编因为历代相传，未便删却，故家严特为增订，望学者勿过事株求可也。

甲、辨指纹三关要诀

二岁以前，病难诊脉，虎口三关，辨其纹色。初风中气，末为命关，男左女右，侧指而看。

[参] 宋人《小儿卫生总微论》载诸处纹状候，谓次指上仄三节，名曰三关，小儿分男左女右看之，且有八般筋脉纹状，以验其病，名曰八片锦。最下一节，名为气关，有纹过者，病才觉重，诸病既生，则气不顺，故名气关也。第二节名为风关，有纹过者，多发惊风，渐加困重，故名风关也。第三节名为命关，有纹过者，则病极而命危殆，故名命关也。按上称三关，与今说有互易处，然解释三关之名称，颇具义理。但风气命之说，相沿已久，改革甚难，故仍之。惟八片锦之形称，其说甚古，且颇新颖，兹录于下。

(一) 鱼刺形，主初惊。在气关，主壮热吐泻；在风关，主初惊才发；在命关，惊极难治。

歌曰：形如鱼刺是初惊，遍体如汤面色青，吐泻躁烦如此证，通肠和气便惺惺。

(二) 垂针形，主泻痢。在气关，主伤冷吐泻；

在风关，主泻转惊风；在命关，主转慢脾风极候。

歌曰：形如悬针泻痢多，惊啼身热定违和，此病若变惊风慢，命关已度是沉痾。

(三)* 水字形，主肺惊。在气关，主涎痰咳嗽虚积；在风关，主气喘呕涎；在命关，主肺败不治。

歌曰：形如水字肺家惊，虚积相传面色青，膈上有涎急须治，命关若过更无宁。

(四) 乙 乙字形，又曰中曲，主食惊。在气关，主食伤吐痢；在风关，主传变虚风（乙形属肝，肝刑于脾）；在命关，转慢脾风不治。

歌曰：形如乙曲病因肝，眼慢惊啼瘕痲偏，冷积为伤传变此，慢脾风已度三关。

(五) 3 去蛇形，主内实外虚。𧈧来蛇形，主外实内虚。𧈧𧈧蛇中卷形，主内外俱虚。此数样皆曲虫，又曰曲蛇。在气关，主疳积，在风关，主疳劳带惊；在命关，不治。

歌曰：形如蛇曲病因深，脾积疔劳又带惊，未过二关宜早治，若过三关更莫论。

(六) 50 长者弓形，短者环形，主疳积。在气关，主吐逆，及疳热吃泥土；在风关，主疳极羸瘦；在命关，不治。

歌曰：形如环弓痞气黄，好食泥土是寻常，此病早求良医治，三关已到命飞扬。

(七) 卮虫 乱纹形，主虫痛。在气关，主气不和。有虫积食诸生物；在风关，主虫咬心腹痛；在命关，主病困极难治。

歌曰：纹乱纵横虫上寻，晓夜啼号不可禁，神佛求遍都无应，安虫祛积得康宁。

(八) ○ 珠形死候，此候不拘三关上下见者，皆为死候。

歌曰：流珠死候不须医，便是沉痾莫疗之，三关若见都休望，安排后事更无疑。

按：王肯堂曰：古人指纹之说，虽各按形晰义，然余尝治之，亦有不专执其形色而投剂者。盖但有是症，即投是药，而亦多验。观此，则辨指纹之形色，不必尽执旧说也。

乙、辨指纹左右要诀

凡看指纹，手络虽同，左肝右胃，亦要明通。肝络现者，血热生风；胃络现者，积热动风。

〔参〕宋人《水镜诀》云：凡看婴孩，须明虎口，辨别三关，男左女右。明医万密斋述汤氏云：男验左手，女验右手。盖取左手属阳，男以阳为主；右手属阴，女以阴为主。然男女一身，均具此阴阳，左右两手，亦当参验。左手之纹，病应心肝；右手之纹，病应肺脾，知此消息，又得变通之意矣。观此，《水镜诀》以男女分左右，汤氏驳之，又以心肝肺脾分左右，皆属臆度，似是而非。若分左肝右胃，虽为汪氏省之所独创，其说较为近理。姑就管见以说明之，心主经脉（即发血管），肝主络脉（即回血管），凡经络交通，左右得以循环者，全赖肝主回血，上行于肺，由肺脉落左心房，逼血循行于手臂，其络脉与经脉并行不悖。故从左手虎口，发现于次指，指纹乃浮露于

表面。胃为十二经络之海，左端与脾膜相连，脾主统血，为动脉宽间之地，且有一支大络，络脉从左过右，入右总回管，由总管横回于手臂，故从右边虎口，发现于次指，指纹乃浮露于表面。滑氏谓指纹宜藏，不宜暴露。石氏谓暴露为血燥生风，故汪氏皆主热盛动风，左主血热，右主积热。论虽翻新，而分际极清。

丙、辨指纹浮沉要诀

外邪初受，指纹乍浮，病尚在表，不足为愁；邪热入里，指纹多沉，病势轻重，宜辨浅深。

[参] 清陈飞霞云：此纹与太渊脉相通，凡有外邪，太渊脉浮，此纹亦浮。盖邪在皮毛腠理之间，故指纹亦显露于外，谓之表症，速宜疏散，启其皮毛，开其腠理，使邪随汗而解。若往来寒热，热重寒轻，指纹半沉，尚在阳明胃经，治宜解肌。若外症身热不已，指纹极沉，已入阳明胃腑，速宜攻下。庸手见其身热，犹以风药治之，盖病在内，治其外，不特病邪不解，适足燥其阴血而增困耳。

37

丁、辨指纹三关病势要诀

纹在初关，虽重无妨；中关已险，末关宜防；三关直透，症多夭亡。

[参] 清余梦塘曰：风轻气重命危之说，亦是板执之论，尝见纹不透关射甲，而其儿已死者；有纹已透关，而其病又渐愈者。但透关之纹，病必重耳。按三关直透，亦有射甲透指必别，射甲者，命关之指纹向外；透指者，命

关之指纹向内也。向内为顺，向外为逆。然亦不可拘，筱廉十余年前，曾侍家严临诊，尝见有病儿指纹透关射甲，症已痉厥兼臻，便闭三日，气升痰壅，病势甚危，每用桃仁承气汤去桂，加羚角猴枣紫雪，一剂即便通痰降，痉止神清，竟得倖全者，数见不鲜。予故谓指纹之说，学者勿过事株求，良有以也。

戊、辨指纹弯向病状要诀

形如弯弓，内外有别。纹向内弯，外感风疾；纹向外弯，内伤饮食。纹入掌中，其腹痛剧，米粒丫枝，并为不吉。势有向背，亦宜辨识，纹势向里，病犹为顺；纹势向外，证必为逆。

[参] 清陈飞霞云：指纹之两头，弯向中指，为内为顺，症为外感风寒；指纹弯向大指，为外为逆，症为内伤饮食。若掌心包络所主，纹入掌中，邪侵内脏，由中气虚寒也，故为腹疼。至于向背顺逆，陈氏已经说明，兹不赘。

以上五种辨法，皆为指纹形状之要诀，临症时亦所常见。寻绎其义，尚有理由，故家严悉仍其旧，略为重订。他如《金鉴》载三关指纹部位纹形歌：大小曲紫伤滞热，曲青人惊走兽占。赤色水火飞禽扑，黄色雷惊黑阴痢。长珠伤食流珠热，去蛇吐泻来蛇疳。弓里感冒外痰热，左斜伤风右伤寒。针形枪形主痰热，射指透甲命难全。纹见乙字为抽搐，二曲如钩伤冷传。三曲如虫伤硬物，水纹咳嗽吐泻环。积滞曲虫惊鱼骨，形似乱虫有蛔缠。脉纹形色相参合，医者留神仔细观。此十三种指形，筱廉实地经验，

不常见，且有验，有不验，不必迷信也。

己、辨指纹各色要诀

小儿指纹，原是青络，浮络本青，何关病毒，隐隐红黄，亦为常络。鲜红深红，热窜血络，紫为热炽，黑乃血毒。

[参]《内经》谓风气通于肝，肝胆之络受风，指纹便见青色。色青而浮者，此伤风寒之候也；色青而沉者，此中阴寒之候也，故《灵枢经》曰：色青则寒且痛。青而兼紫，则为伤食，食积乃有形之物，壅遏脾胃，气机不能宣化，每致食积化火，火旺则生风，上窜肺经，则痰壅气升，刺激神经，则痉瘲昏厥。世俗便称急惊风，儿科凿分为食惊痰惊，见形取名，种种讹传，不胜枚举，皆由未曾研究病理之故耳。故陈飞霞曰：病若抑郁日久，肺脾愈困，荣卫愈涩，则风痰食热，固结中焦，纹多青而兼黑，急宜攻下，庶有生机，误认惊风，百无一救。陈氏又云：黄为中和之气，红乃文明之色，红黄隐隐，焉有不安。若鲜红多由邪闭经络，经气郁，则络气亦郁，郁则邪从火化，指纹每见深红。若婴儿中气虚弱，荣卫不充者，纹必淡莹。淡而兼红，此脾胃气虚之应也。按：指纹色紫络热之征，固已。盖因络脉中血色素本属青紫，络血郁，则纹色见青；络血热，则纹色紫而兼青。若指纹色黑，皆属络瘀。故《灵枢经》云：鱼际暴黑者，留久痹也。盖因血流久痹者，其络中炭素满布也。其症有中寒中恶之分，中秽恶，指纹则浮而紫黑，其色显明；中阴寒，指纹则沉而青黑，其色晦黯，此皆指纹分五色之原理也。石芾南云：滑

氏谓红为伤寒之说，显背经旨。余梦塘曰：儿科书中，谓紫为风，红为伤寒，青为惊，及黑是人惊，黄是雷惊之类，则是惊风家之乱谈，颠倒错乱，全不可信者也。故家严参生理学说，新诠络血之色素，发明病理，将前哲原文，一一删改以增订之。

庚、辨指纹淡滞要诀

指纹淡淡，先天素怯，脾胃本虚，慎防攻削。关纹涩滞，邪气久留，或通或攻，临证推求。

[参] 陈飞霞云：小儿禀受阳虚者，指纹四时皆淡，虽病亦止淡红淡青淡紫而已。盖淡红虚寒，淡青虚风，淡紫虚热。此等之儿，根本不坚，无论新病久病，总归于虚，大忌攻伐。如因风热与饮食相搏，荣卫阻滞，升降不通，所以指纹推之转涩，全无活泼流利之象，急宜推荡。若三关纯黑，推之不动，则为死症不治。

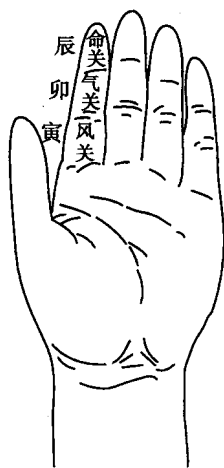


辛、辨色脉合参要诀

经脉络脉，《灵》《素》并阐，纹色脉象，亦要合参。纹色浮者，其脉多浮；纹色沉者，其脉多沉，纹色虚淡，脉亦多虚。随机证察，毋执一偏，草率一望，辄为病偏。

[参] 余梦塘曰：手纹与太渊脉，气本相通，乳子病看手纹，尤准于诊脉。盖看脉者，先调气息，静验病情，迟数浮沉，细细探之，方能明白。小儿常怯生人，见面每多啼哭，呼吸先乱，神志仓忙，脉病与否，焉能审确。惟手纹有色可见，啼哭亦无变更。且诊脉者，探

其神也，观纹者察其色也，辨色原易于讨神，色如是，神定如之，断无不合之理。如伤风者，脉必浮，手纹色青，亦浮露于外，原是厥阴肝，在天为风，在地为木，其色青，儿若伤风，肝木必旺，故纹青为表症，为伤风候也。邪若入里，营卫阻滞，必蕴为热，脉或长，或洪滑，或弦数，属半表半里，手纹亦半浮半沉，其色中青而外带红，此外感热症也。若脾胃积滞，阻抑中焦，食积化火，火旺生风，风动冲肺，痰气上逆，脉必沉实而滑，手纹则亦沉，其色青紫而暗。脉洪大弦数有力，为实热，手纹则深红，或紫而鲜明。若虚热者，脉洪数无力，手纹则淡红而柔软。脉迟为虚寒，手纹则淡红一线，旁有白影（白影浮于淡红之上，须斜视之乃见），阴寒直中。脉沉而迟，手纹则沉而青黑（青紫者，旁有红艳，青黑者，旁带晦暗）。脉顽硬坚劲，为无胃气，为真脏脉，纹则粗硬如露青筋，推之血不流利，亦为无胃气。由此参之，手纹与脉，其气相通，其理故同，诊脉可也，看纹亦可也。苟得其诀以扼要，谁谓指纹之不验



而不可信也哉！其说如此，然必外邪深入血分，则指络形色，变而发现。但可以决病之浅深逆顺，症之寒热虚实，不能决病在何经何脏也。故先宜望面色，审苗窍，查问病源，庶有精确之诊断，而用药始能无误，业儿科者其注意之。

第二章 问诊纲要

未诊先问，最为有准，小儿有病，首贵详审。外感六淫，内伤乳食，有无胎毒，必先细诘。

[参] 病，藏于中者也；证，现于外者也。工于问者，非徒问其证，殆欲就其现证以审其病因耳，故经谓治病必求其本，本者，受病之原因也。小儿病因，或外感，或内伤，或遗传胎中病。凡初诊大纲未定，最宜详审。病家不可讳疾试医，医者必须委曲细问。盖病有显性症，有隐性症，决无一诊而能悉知其隐微之病情也。问诊之法，虽证因错杂，但贵心有权衡，则可审其轻重真伪，而折衷于当矣。惟诊病虽须详问，仍当色脉合参，不可徇乳母或小儿之言，为其所惑。

第八节 问病因要诀

初起何因，前见何症，后变何症，详诘病情，约计十种，定为问诊，熟此要诀，乃可临证。

[参] 《内经》谓一者因得之。又云：先其所因，伏其所主。查婴儿病因，有先天之因。如因父母禀受所生者，胎弱胎毒是也。胎弱者，皆因父母精血之不足也。胎毒者，皆由父母欲火之有余也。后天之因有三：一如衣太厚则热，太薄则冷，冷热之伤，此外因也；二若乳

多则饱，乳少则饥，饥饱之伤，此内因也；三若客忤中恶，坠仆所伤，此不内不外因也。若小儿至成童，外感内伤，大致与少壮相同。但因饮食自倍，肠胃乃伤者最多。故谚云：小儿病，多从食上起，若要小儿健，常带三分饥与寒。此皆临症探源之大要也。故凡初起何因，必先问明为第一要诀。

第九节 问诊十法要诀

一问寒热，二问其汗，三问头身，四问胸间，五问饮食，六问睡眠，七问饥渴，八问溲便，九问旧病，十问遗传。

[参] 景岳《十问篇》云：一问寒热二问汗，三问头身四问便，五问饮食六问胸，七聋八渴俱当辨，九问旧病十问因，再兼服药参机变，见定虽然事不难，也须明哲毋招愆。虽为问法之要略，而王秉衡《重庆堂随笔》谓人皆服其周匝而犹未尽善也云云，可见问法之未易得要也。家严十问，乃当时临症之问法，与景岳同而不同者，专为儿科问诊之纲要也。

43

甲、问寒热要诀

寒热往来，恶寒畏热，孰重孰轻，分际宜晰。

[参] 张景岳云：问寒热者，问内外之寒热，欲以辨其在表在里也。经谓人伤于寒则病为热，故凡病身热脉紧，头疼体痛，拘急无汗，而且得于暂者，必外感表证也。若无表证，而身热不解者，如非伏气，即属内

伤。以问证望色诊脉合参，自得其真，虽然伏气多属积热，内伤多属阴虚。寒者多虚，而实寒者间亦有之；热者多实，而虚热者最不可误，此寒热之在表在里，不可不辨也。王秉衡驳其问寒热云：首二条，皆是伤寒，若发热不恶寒者，温病也。纵挟新感风寒而起，先有恶寒，迨一发热，则必不恶寒矣，此伏气温病也。外感风温暑热，首先犯肺，肺主皮毛，热则气张而失清肃之权，腠理反疏，则凛冽恶寒，然多口渴易汗，脉证与伤寒迥异。经云：气盛身寒，得之伤寒；气虚身热，得之伤暑。所谓身寒者，寒邪在表，虽身热而乃恶寒也。暑为阳邪，发热即恶热，亦有背微恶寒者。曰微，仍不甚恶寒也。况但在背，与周身恶寒迥别，可不细问哉！即内证发热，亦不可专属阴虚。香岩先生云：或食积，或瘀血，或痰凝，或气滞，皆能发热，必辨证明白，庶不误治。



乙、问汗要诀

查问其汗，有汗无汗，邪汗真汗，汗少汗多，汗起何处，汗止何所，汗味咸淡，详询若何。

[参] 张景岳云：问汗者，亦以察表里也。凡表邪盛者必无汗，而有汗者邪随汗去，已无表邪，此理之自然也。故有邪尽而汗者，身凉热退，此邪去也。有邪在经而汗在皮毛者，此非真汗也。有得汗后，邪虽稍减，而未得尽全者。犹有余邪，又不可因汗而必谓其无表邪也，须辨脉证而详察之。又如温暑等证，有因邪而作汗者，有虽汗而邪未去者，皆表证也。总之，表邪未除

者，在外则连经，故头身或有疼痛。在内则连脏，故胸膈或生躁烦。在表在里，有证可凭；或紧或数，有脉可辨。须察其真假虚实，孰微孰甚而治之。他如阳虚而汗者，阴虚而汗者，火盛而汗者，过饮而汗者，此汗证之有表里阴阳，不可不细察也。

外感恶寒，身偎母怀，其寒不除，汗出乃解。内伤恶寒，一投母怀，其寒即轻，不汗亦解。外感时病，寒热往来，有定期者，则为疟症；无定期者，则为别症。恶寒无汗，身热不渴，风寒表症；恶热自汗，渴不恶寒，温热里症。恶寒蜷卧，四肢厥冷，身不发热，直中阴症；恶热平卧，手足虽冷，腹中灼热，伏气阴症。凡属外感，背热于腹，但手背热，手心不热，凡属内伤，腹热于背，但手心热，手背不热。日晡潮热，外感实证；子午潮热，内伤虚症。

[参] 发热无汗，邪在表也；内热便硬，邪在里也。昼若烦热而夜安静，是阳旺于阴分，其病在阳；若夜烦热而昼安静，是阳陷于阴分，其病在阴。喜冷恶热，皆属阳病；喜热恶冷，皆属此亦问症之要领也。

丙、问头身要诀

欲问头身，外内须别，属外感者，头疼身痛，常痛不止；属内伤者，头身虽痛，时痛时止。外感头痛，须辨六经，痛起脑后，甚则项强，太阳经症；痛在额前，或连目珠，阳明经症；痛在两角，或连胁疼，少阳经症；痛在巅顶，甚则肢冷，厥阴经症。太阴中湿，头痛鼻塞，腹满自利，肺脾同病；少阴中寒，头痛连脑，指

甲色青，心肾同病。头仰视上，天钩暴发，头倾视深，精神将夺。头痛如破，甚则发痉，风火相煽；头痛而晕，剧则昏厥，痰火上升。头痛怕风，恶寒无汗，身热脊强，为风寒症；头疼恶风，身热自汗，鼻鼾肢痲，为风温症。伤寒身痛，项背反张，筋甚挛急；中湿身痛，体势沉重，不能转侧。似此勘问，病有正的，若看婴儿，须望形色。

[参] 张景岳云：问其头，可察上下；问其身，可察表里。头痛者，邪居阳分；身痛者，邪在诸经。前后左右，阴阳可辨；有热无热，内外可分。如头痛属表者，多因于风，是其常也。然亦有热盛于上，阳亢不能下降而痛甚者。又如头痛属里者，多因于火，其常也。然亦有阴寒在上，阳虚不能上达而痛甚者。若阴虚头痛者，举发无时；阳虚头痛者，恶寒呕恶。若问头晕头重者，亦可因之以辨虚实。凡病中眩晕，多因清阳不升，上虚而然。如丹溪云无痰不作晕，殊非真确之论。但当兼形气分久暂以察之。观《内经》曰，上虚则眩，上盛则热痛，其义可知。至于头重，尤为上虚。经曰上气不足，脑为之不满，头为之苦倾，此之谓也。又凡身痛之甚者，亦当察其表里，以分寒热。其若感寒作痛者，或上或下，原无定所，随散而愈，此表邪也。若有定处，而别无表证，乃痛痹之属。邪气虽亦在经，此当以里证视之，但有寒热之异耳。若因火盛者，或肌肤灼热，或红肿不消，或内生烦渴，必有热证相应，治宜以清以寒。若并无热候，而疼痛不止，多属阴寒，以致血气凝滞而然。经曰：痛者，寒气多也，有寒故痛也。必温其

经，使血气流通，其邪自去矣。若久病虚剧，而忽加身痛之甚者，此阴虚之极，不能滋养筋骨而然。王秉衡驳辨问头身云：第三条，阴虚头痛，叶氏云：多属阳亢，未可峻补。第四条，阳虚头痛，百无一二之证。至于眩晕，不可与头重混同立论。头晕因肝火挟痰者多，头重则属湿者多。经云邪之所在，皆为不足，上气不足，脑为之不满，耳为之苦鸣，是言邪乘虚客之，非竟言虚也。景岳于二证，皆主上虚，清阳不升，亦百中一二耳。王孟英云：头痛及项背脊腰臂腿诸疼，有内伤外感之别。内伤多虚，亦属气不宣行；外感多实，总由客邪阻气。李晋恒别驾，谓督是一身之总气管，知此可悟其治法矣。就余所见，此就小儿至成童，有知识而能答问者，依此问法，可为诊断之一助。若初生婴儿，则无所庸其问矣。即问乳母，亦不能知其为头痛否，为身痛否，全在医者望诊与按诊。如见其婴儿啼哭时，两眉频蹙，非腹痛，即头痛矣。按其头部发热，两太阳脉及耳前脉，跃跃震手，尤为头痛之明证。若见其身偎母怀，忽啼忽哭，项强背反，手足乱动，皆属身痛之明证。虽然头为精明之府，内含脑髓，凡属感邪外触，内热上蒸，无不关于脑神经。身为全体之总称，别于头部手足而言，凡身热体痛，项脊俱强，无不关于脊髓神经。婴儿体质柔脆，不胜外邪刺激，所以婴孩多痉厥癰疽之候也。不明生理，不知病理之儿科，一见即称曰惊风，伪撰许多惊名以欺世，于儿科外别创一惊科，酿成惊风世界者，皆此辈造之也。噫！

丁、问胸间要诀

查问胸膈，结胸痰气，或痛或闷，清晰病机。胸痛少气，水阻痰积；胸凭仰息，其病喘喝。胸膈胀满，有虚有实；胸膈秘结，或痛或塞。

[参] 张景岳云：胸在膈上，上连心肺，下通脏腑，其病极多，难以尽悉。而临证必当问者，为欲辨其有邪无邪也。凡胸膈胀满，则不可用补；而不胀不满，则不可用攻，此大法也。然痞与满不同，当分轻重。重者，胀塞中满，此实邪也，不得不攻。轻者，但不欲食，不知饥饱，似胀非胀，中空无物，乃痞气耳，非真满也。此或因邪陷胸中者有之，或因脾虚不运者有之，病者不知其辨，但见胃气不开，饮食不进，问之亦曰饱闷，而实非真有胀满，此在疑虚疑实之间，若不察其真确，未免补泻倒施，必致多误，则为害不小。倘势在危急，难容少缓，亦必先问其胸宽与否。若元气已虚，而胸膈又胀，是必虚不受补之证，若强进补剂，非惟无益，适足以招谤耳，此胸膈之不可不察也。王秉衡驳辨问胸云：叶氏谓胸膈胀满，固不可补，不知饥饱，似胀非胀，是浊气不清，但当理滞气，不宜骤用参术补住浊气而为胀。经云浊气不降，则生腹胀，即宜补者，须分气血，虚而兼滞者，疏补宜兼，俗云虚不受补者，未知疏补兼行之法耳。愚谓胸次如天，天空则生气流行不息。然虚痞可补之证，间亦有之。气虚者宜温补，阴虚者宜滋填。若痰涎凝聚，饮食停滞，及温热疫证，邪踞膜原者，皆宜开泄为先，补药固忌，即凉润之品，亦在所

禁。恐病人言之未确，医者必手按其胸腹，有无坚硬拒按，可断其邪之聚散，最为诊要。更有内痈一证，尤当留意。

戊、问饮食要诀

病从口入，多由饮食，何物所伤，必先详诘。喜冷饮者，多内热症；喜热饮者，多里寒症。得食稍安，多属虚症；得食更甚，多属实症。冷饮能多，火盛实热；冷饮不多，津干虚热。大渴引饮，胃肠燥热；渴不引饮，脾胃湿热。胃气强者，病亦能食；胃气弱者，病不能食。好食苦者，则为心病；好食酸者，则为肝病；好食甘者，则为脾病；好食辛者，则为肺病；好食咸者，则为肾病。

[参] 张景岳云：问饮食者，一可察胃口之清浊，二可察脏腑之阴阳。病由外感而食不断者，知其邪未及脏，而恶食不恶食者可知。病因内伤而食饮变常者，辨其味有喜恶，而爱冷爱热者可知。素欲温热者，知阴脏之宜暖；素好寒冷者，知阳脏之可清。或口腹之失节，以致误伤，而一时之权变，可因以辨。故饮食之性情，所当详察，而药餌之宜否，可因以推也。故凡诸病得食稍安者，必是虚证。得食更甚者，或虚或实皆有之，当辨而治也。王秉衡驳辨问饮食云：得食稍安者，必是虚证，未尽然也，痰火证虫证，皆得食稍安。而痰火证更有初服温补极相安者。其中消善食，属于火者，是实证矣。亦有火盛反不能食者，胃热不杀谷也。更有阴液久耗，胃阳陡越之阴中证，能食善饥，俨如消证，但脉必

虚大，按之虚软无神，纵与大剂填阴，亦不救也。虽不多见，不可不知。至于热证喜饮，寒证恶饮，人皆知之。而热证夹湿夹痰者，亦不喜饮，或喜沸饮，皆不可误指为寒也。喜饮而不多者，古人但以为阴虚，而不知亦有夹痰饮者。

己、问睡眠要诀

欲问睡眠，最宜察实。不食不眠，胃多积食；嗜睡恶饮，脾多积湿。睡中咬牙，将病风热；睡中惊窜，将发抽搐。睡时忽咳，痰滞食积；睡时狂叫，猝惊胆怯。邪在阳分，朝热暮凉；夜可安眠，邪陷阴分。暮热朝凉，夜不安眠；阴虚恶阳，夜静昼烦。暮能宁睡，阳虚恶阴；旦安暮乱，夜难熟睡。

〔参〕睡者，倦而闭目也；眠者，翕目而寐也。外感初起，多睡兼身重者，湿热阻滞于经脉也。内伤脾虚，有痰而多睡者，寒湿凝滞于中焦也。不论外感内伤，伏热灼阴，二便俱利而身痛多睡者，阴伤也。他如阳明之为病，卧不安者，胃不和也。少阴之为病，但欲寐者，邪陷心脏也。似睡非睡者，心神内亏也。神昏沉睡者，心窍内闭也，一问即可诊断其病情矣。即诊察小儿时，亦以其睡眠中为最便。

庚、问饥渴要诀

饥者甘食，食不暇择。饥而善食，胃火剧烈；若中消者，多由虫蚀。饥不欲食，肝阳郁极；如吐蛔者，须防发厥。脾疳虫积，腹饥难耐；恣食泥炭，胃气易馁。

渴者甘饮，随症辨明。实热之渴，大渴引饮；湿热之渴，渴不引饮。虚热之渴，渴喜热饮；风火之渴，渴喜冷饮。口干消渴，肝胃热病；口燥不渴，脾胃湿病。先渴后呕，水停心下；脾胃不和，先呕后渴。火烁胃液，肝胃不和。症属虚寒，口多不渴；症属实热，口多燥渴。

[参] 饥，饿也。渴，欲饮也。饥者易为食，渴者易为饮，此生理之常也。若病则有饥不欲食者，渴不引饮者。凡小儿胃中嘈杂，饥不能耐者，除外感症外，其病有三：一因胃火中烧，二因虫饥求食，三因肝火挟痰。至若问渴，张景岳云：问渴与不渴，可以察里证之寒热。而虚实之辨，亦从此见。凡内热之甚，则大渴喜冷，饮水不绝，而腹胀便结，脉实气壮者，此阳证也。若口虽渴而喜热不喜冷者，此非火证，中寒可知，既非火证，何以作渴？则水亏故耳。凡病人问其渴否，则曰口渴，问其欲汤水否，则曰不欲。盖其内无邪火，所以不欲汤水；真阴内亏，所以口无津液，此口干也，非口渴也，不可以干作渴治。若阳邪虽盛，而真阴又虚者，不可因其火盛喜冷，便云实热。盖其内水不足，欲得外水以济，水涸精亏，真阴枯也，必兼脉证细察之。王秉衡驳辨问渴云：喜热饮为中寒水亏，叶氏云，水亏则内热，岂有中寒之理。凡喜热饮者，皆郁滞不通畅，故得热则快，得冷则遏，并非水亏也。若水涸精亏者，宜滋阴，反用热药，是杀之也。其曾孙王孟英云：渴喜热饮，渴不多饮，湿热证多有之，皆属痰饮阻遏气机耳。

辛、问溲便要诀

详询溲便，或通或塞，为燥为溏，为清为浊，青黄赤黑，辨明形色，虚实寒热，方能深悉。

[参] 张景岳云：二便为一身之门户，无论内伤外感，皆当察此，以辨其寒热虚实。盖前阴通膀胱之道，而其利与不利，热与不热，可察气化之强弱。凡患伤寒而小水利者，以太阳之气未剧，即吉兆也。后阴开大肠之门，而其通与不通，结与不结，可察阳明之虚实。且也大便通水谷之海，肠胃之门户也。小便通血气之海，冲任水道之门户也。二便皆主于肾，本为元气之关，必真见实邪，方可以议通议下。否则最宜详慎，不可误攻。使非真实而妄逐之，导去元气，则邪之在表者，反乘虚而深陷，病因内困者，必由泄而愈亏。所以凡病不足，慎勿强通。最喜者小便得气而自化，大便弥固者弥良。营卫既调，自将通达，即大便秘结旬余，何虑之有！若滑泄不守，乃非虚弱者所宜，当首先为之防也。凡小便，人但见其黄，便谓是火，而不知人逢劳倦，小水即黄。焦思多虑，小水亦黄；泻痢不期，小水亦黄；酒色伤阴，小水亦黄。使非有或淋或痛热证相兼，不可因黄便谓之火，余见逼枯汁而毙人者多矣。经曰中气不足，溲便为之变，义可知也。若小水清利者，知里邪之未甚，而病亦不在气分，以津液由于气化，气病则小水不利也。小水渐利，则气化可知，最为吉兆。若大便热结，而腹中坚满者，方属有余，通之可也。若新近得解，而不甚干结，或旬日不解，而全无胀意者，便非阳

明实邪。观仲景曰：大便先硬后溏者，不可攻。可见后溏者，虽有先硬，已非实热。矧夫纯溏而连日得后者，又可知也。若非真有坚燥痞满等证，则原非实邪，其不可攻也明矣。王秉衡驳辨问溲便云：中气不足，溲便为之变，不可因溺黄而谓之火，强逼枯汁以毙人。叶氏谓：妄用通利，则逼枯汁，如养阴清热，何至逼枯汁。若经言变云，非云小溲黄赤也，统指二便异于常时也。小溲或不禁，或淋漓，短少频数，或清而多，大便或滑泄，或燥结，皆异于平日之调和，故谓之变。况劳倦焦思，泻利酒积为湿火；若暑热下痢，小便淋痛，乃邪火。当分别而治，不可云无火，而用温补以误人。经言邪之所在，皆为不足，因不足而邪客之为病，后人脱却上文邪之所在句，竟言虚而用补，谬矣。大便亦要调和，若愈固者，乃燥结也，当濡养为主。或固结在老年，防有噎膈之患，不可云弥固弥良。愚谓大便固结，必胸腹舒泰，饮食能安，圉不努挣者，始谓可喜。溏而频解，解而腹中始为快者，此《内经》所云得后与气，则快然而衰也。否则非痰饮内阻，则气郁不宣。即泄泻在温热暑疫诸病，正是邪之去路，故不可一问溏泻，辄以为虚寒，而妄投温补止涩也。须问其解之热与不热，色之正与不正，必不觉其热，而稀溏色正者，始可断为中气不足也。更有痢症痘疹将发，而吐泻先作者，前辈皆不说明，故详赘之。

壬、问旧病要诀

小儿旧病，癖积最多。病症哮喘，皆属沉疴。凡成

疳癆，多由虫积；凡成谷癆，多由食亦；凡变奶癆，多由乳缺。似此六症，皆为夙疾。临症探源，必先究诘。痘疹经过，尤须问及。

[参] 旧者故也，新之对，《内经》谓新病未已，故病复起者，近世所谓夹症是也。夹症者，或夹伏气，或夹内伤，或夹夙病，新旧夹发也。叶天士所谓兼别病累瘁，须细体认也。故凡治儿病，寒者温之，热者清之，虚者补之，实者泻之，其常也。若遇有内伤夙病之人，适患外感时病，不得用峻汗峻攻之法。必参其人之形气盛衰，客邪微甚，本病之新久虚实，向来之宜寒宜热，宜燥宜润，宜降宜升，宜补宜泻。其间或夹痰，或夹瘀，或夹水，或夹火，或夹气，或夹食，或夹癖，或夹虫。务在审证详明，投剂果决，自然随手克应。故治外感夹内伤者，首必辨其虚中实，实中虚，最为要诀。临症时必先问其旧病者，观其现在，查其既往，防其将来，此断病要法也。

癸、问遗传要诀

凡胎中病，皆属遗传。孕时不谨，胎气熏染。推原其因，学说繁杂。提要查问，寒热虚实。恣食生冷，任卧贪凉，则为胎寒；好食煎炒，多烘火炉，则为胎热。一寒一热，其证不一。父强母弱，生女必怯；父弱母强，生男必弱。胎稟不足，皆为胎弱；胎火有余，则为胎毒。最剧烈者，遗传霉毒。

[参] 《小儿卫生总微论》曰：儿自生下至一腊年后，有病者为胎中病。多是未生之前，在母胎妊之时，

母食毒物，胎有所感，至生下之后，毒气发而为病。又有母于妊娠之时，失于固养，气形勿充，疾疢因之。故《圣济经》言病生于中者，与生俱生也。万密斋云：小儿自周岁有病者，皆为胎疾，其中惟胎毒为最多。如思虑之妄，火生于心；恚怒之发，火生于肝；悲哀之过，火生于肺；酒肉之饕，火生于脾；淫佚之纵，火起于肾。五欲之火，隐于母血之中，即是毒也。男女交媾，精气凝结，毒亦附焉，此胎毒之原也。观东垣红瘤之说，丹溪胎毒之论，则胎毒之繁可见矣。如谓儿在母腹，饥则食母之血，渴则饮母之血，及其破胎而出，口有余血，拭之不净，咽下腹中，是谓胎毒。岂知口内之血，乃母临产恶露，渍入口中，未必是母腹中所衔之血也。既云咽下腹中，则入于大肠界，从大便出矣，安得留在命门，待时而发耶！丁仲祜云：遗传病，如佝偻质斯、癌肿、心脏瓣膜病、痛风等，时有遗传他人。或传易罹此等疾病之素因于他人者。故凡欲问遗传，则其人之父母兄弟、祖父母、伯叔伯母等，均必事无巨细，一一有以详加审问之。有父母虽无遗传之疾病，而其远祖尚能遗传之者。凡癫痫、精神病，概为遗传。其问否，大有影响于其定治疗法与豫后者也。校以上十问，虽为家严诊断之心传，然诊断小儿之病患，与成人迥殊。小儿不能自述其病状，而遇非所素亲狎之人，又或示憎恠，或且啼泣，既不能自述其病状，则不能详悉检查其现症，是当追问既往症于其父母，或看护者。且须详询父母健否，有无结核等之遗传病；妊娠中母体若何；小儿之血族生死若何，如有死亡者，则为何种病症；哺乳

之关系若何，为生母耶，为乳母耶，为人工营养法耶；生后若干月，始发生乳齿，其后之经过良否。其他询问住居、姓名、年龄，生后曾否患麻疹痘疮等，与成人同。日本汉医大家，如和田东郭辈曰：小儿胎毒系先天，而世医不知之，或言分娩时误饮瘀血，为可笑。凡诊其毒，先以指头按肋下，必有凝结，而因其缓急，可察毒之轻重。又面色晦白，或暗黑，或过光泽，皆属胎毒也。若受父母梅毒者，最为难治。患梅毒者，兼发痘疮，尤多危候。即龟胸龟背，由霉毒而成亦多。芽儿衄血，且鼻塞者，亦属胎毒。他如狂喘癆三症，多属胎毒。毒攻心中者曰狂，攻骨骺者曰癆，攻胸膈者曰喘，其根同而枝叶异也。若狂愈而变癆者，必死。若哑者，系胎毒壅闭上部也。耳不聾者可治，耳聾者不治。若腋臭及聾耳有脓者，皆属胎毒。若幼时患哮喘者，一旦治愈，后有发痴病或心风者，皆系先天遗毒，故为难治。若患痴病治愈，后变哮喘者，又有幼小无事，少壮始患癫痫狂心风者，亦系先天遗毒。但因其人体气有迟速耳，吾门即名之曰胎病（胎病名出于《素问·奇病论》，可以征焉）。

第三章 闻诊纲要

中医听声，闻其五音，以别其病，病无遁情。

[参] 声者，耳官之所感觉者也。凡人声管与肺气相激荡，则成声。声成文者谓之音。如《礼乐记》注：单出曰声，杂比曰音是也。古以其清浊高下，分为宫商角徵羽五音，乐器用之为标准，医科用之为闻诊。如陈廷芝《难经辨疑》曰：五脏有声，而声有音，肝声呼，音应角，调而直，音声相应则无病，角乱则病在肝。心声笑，音应祉（别作徵），和而长，音声相应则无病，祉乱则病在心。脾声歌，音应宫，大而和，音声相应则无病，宫乱则病在脾。肺声哭，音应商，轻而劲，音声相应则无病，商乱则病在肺。肾声呻，音应羽，沉而深，音声相应则无病，羽乱则病在肾。观此，则医者果能静心察之，知表里脏腑寒热虚实诸病之情态，庶无所遁矣。

57

既明望问，细听其声。痛实声浊，寒虚声轻。噪喊热甚，遽叫神惊。啼声不出，难望求生。

[参] 《幼科金鉴》歌诀云：啞煎不安心烦热，嗝声重感寒风，有余声雄多壮厉，不足声短怯而轻。其注曰：啞煎不安者，乃心经内热，故烦躁不宁也。嗝声，音哑也；声重，声浊也，此为外感风寒也。有余之症，其气实，故声雄大而壮厉。不足之症，其气虚，故声怯

弱而轻短。按：风寒犯肺，声重音哑者，实因肺气不宜，痰阻声管，音不清而其声似哑也。《金鉴》原注，尚欠明晰。

心系急者，多言笑声；肝系急者，多狂呼声；脾系急者，多歌唱声；肺系急者，多悲哭声；肾系急者，多呻吟声。似此五音，脏病相应；原其病理，交感神经。综而言之，声音臭味，载在《难经》。耳鼻并用，一一辨清。照此察病，病情分明。

[参]《内经》谓里擷筋骨血气之精，而与脉并为系，上出于脑后，入于项中。观此，则古人所谓系者，即脑系也，近世所谓神经系是也。如心系急则笑，肺系急则哭等症，虽由脏性之各异其情，实皆五脏各有交感神经之作用也。《幼科金鉴》歌诀云：诊儿之法听五声，聆音察理始能明，五声相应五脏病，五声不和五脏情。心病声急多言笑，肺病声悲音不清，肝病声呼多狂叫，脾病声歌音颤轻，肾病声呻长而细，五音昭著症分明。其注曰：小儿之病，既观其色，又当细听其声。盖笑呼歌悲呻五声，内应心肝脾肺肾五脏也。五声不和，则知五脏有病之情矣。如心病则声急喜笑，肺病则声悲音浊，肝病则声狂叫多呼，脾病则声颤轻如歌，肾病则其声长细如呻吟。歌与诀虽属分明，然尚不知内脏之有交感神经之作用也。

第十节 闻声音要诀

寒则声静，热则声噪；虚则声低，实则声高。声战为

寒，声壮为热；声塞为痰，声浊为湿。声重鼻塞，皆风寒症；声哑气逆，多风痰症。若声浊者，多痰火症。气衰声微，多属虚症；气盛声响，多属实症。腹中雷鸣，肠风飧泄；闻声即惊，肝虚胆怯。

〔参〕闻声，听病儿之声音呼吸也。闻诊法者，医生闻病儿自现其病状，据之以与自己之学问经验，互相比较，为诊断材料者也。若声音清朗如常者，形病气不病也。始病即气壅声浊者，邪干清道也。攒眉呻吟者，头痛也。摇头而语，以手扞腮者，齿颊痛也。噫气以手抚心者，中脘痛也。摇头而言者，胸腹痛也。呻吟不能转身，坐而下一脚者，腰痛也。呻吟不能行步者，腰脚痛也。暴哑者，风痰伏火，或怒喊哀号所致也。若久病形羸声哑者，为童子癆。喉中有肺花疮也。此皆闻诊之大要也。

第十一节 闻啼哭要诀

哭而无泪，多属燥症；哭而多泪，多属痛症。啼而不哭，多腹痛症，哭而不啼，多惊痉症。忽然惊啼，肝火冲心；骤然狂叫，胃热蒸心。

〔参〕小儿能言语后而哭泣者，固必自鸣其心身之苦痛也。然其泣之原因，或为痛痒，或欲食物，大人尚易悟之。若至惟以啼泣为自鸣意志者之赤子（不能言者），则其泣声，宛为言语之代表矣，为亲者可不注意之乎！即其泣也，未必如大人所思及之苦痛，又未必为饮母乳。或衣服之不适肤也，或腹痛、或发热也，均无

一不为啼泣之因焉。育儿者，宜常侍小儿身侧，诊断其何以啼泣之故。若单哺以乳汁，欲止其啼泣者，是非直为无智之母，且为不慈爱之人矣。然苟检视小儿身上无有异常，而泣仍不止者，是必为腹痛发热之故。腹痛时之泣法，其声为オギヤオギヤ，其下肢常向腹部牵动。又虽其状如是，而或泣或止者，是腹痛有间断之征也。若腹痛如刺如切，泣声ギャギャ，宛若呼吸断绝，以手抚其腹部，则抵抗力甚强者，恐其为便秘也。

第十二节 闻呼吸要诀

呼吸困难，肺痰上塞；呼吸喘急，肺气上逆。猝中风热，喘鸣肩息，气不接续，语言吸吸。呼而音嘶，则为鸦声；呼无转音，则为直声。吸而微数，病在中焦；实者当下，虚者不治。上焦吸促，下焦吸远。呼吸动摇，此皆难治。

[参] 呼者，嘘气外出也；吸者，引气内入也。呼则出，吸则入者，肺气一涨一缩之外候也。三岁以下之小儿，其呼吸专营于横膈膜（腹式），故浅而频数。一分时呼吸之数，于生后数月内，为三十五（睡眠时）至五十（醒觉时）；至二岁后，则为三十；六岁后，则为二十以下。其年龄次第增长，则呼吸数即次第减少。欲静听小儿之呼吸数，而审其安适与否，则当以呼吸数与脉搏，两两比较。平时一呼吸运动间，其脉搏为三半至四。若呼吸困难之际，则此之关系亦变，一呼吸运动间，其脉搏仅二至三。其呼吸困难，因补助筋之皆动

(鼻翼颈筋紧张)，与胸廓下部（即沿横膈膜之附着部之处）之陷没而知。然横膈膜动作旺盛之时（例如啼泣时），呼吸实不困难，而其胸廓下部亦陷没者，此因软弱肋骨之强度，对于收缩之横膈膜，其抵抗力微弱故也。他如生后三月内之小儿，或佝偻病性之小儿，其肋骨俱软弱者，其胸廓下部亦俱陷没，此虽于安静呼吸之时，亦可辨之。

第十三节 闻咳声要诀

声哑而咳，寒水伤肺；声破而咳，癆热损肺。连声而嗽，则为顿咳；气呛无痰，则为干咳。饮咳稀痰，燥咳粘痰，火咳无痰，癆咳胶痰。痰声漉漉，多属肺绝；久病呛呃，多属胃绝。

[参] 小儿严寒时，偶闻咳嗽声，干燥轻小而痛者，急性喉头炎也。其吼声尤剧者，实扶的里亚之喉证也。呼气短而吸气长者，为百日咳。咳嗽之声，宽而且湿，而身体有热者，恐为肺炎。常人虽仅知此，则闻儿之咳声ユンコンヒコ者，已可约知其为百日咳。而闻女之咳声コホンコホヒヒ者，已可约知其为实扶的里亚矣。若小儿咳嗽兼呕吐者，病不足惧。咳嗽之声本大，继而其声忽无者，极危险之症候也。

61

第十四节 闻痛声要诀

声如羊叫，则为心痛；声如犬叫，则为肝病；声如牛

叫，则为脾病；声如鸡叫，则为肺病；声如猪叫，则为肾病。此为五病，仲阳所传，历代相衍。

[参] 病者，脑神经病也。卒然倒仆，口吐涎沫，为羊豕之声，手足搐搦者是也。俗亦谓之羊痫风。钱氏《小儿直诀》云：五病皆随脏治之，每脏各有一兽。如羊病，目瞪吐舌，羊叫，心也；犬病，反折上窜，犬叫，肝也；牛病，目直视，腹满，牛叫，脾也；鸡病，惊跳，反折手纵，鸡叫，肺也；猪病，如尸吐沫，猪叫，肾也。五病重者死，病后甚者亦死。按：病发作羊犬声者，乃声管为风痰梗塞，故特发异声，不必强以五畜按五脏也。《千金》引徐嗣伯风眩论，谓痰热相感而动风，风火相乱则闷瞽，故谓之风眩，大人曰癲，小儿则为病，其实则一云云。巢氏《病源》亦曰十岁以上为癲，十岁以下为病。是癲病癲狂之病，六朝以前，未尝不知病在于脑。唐宋以降，则不复知癲病即顶巅之颠，遂有五病五兽，分属五脏之说。观《病源》五癲，尚不以五脏立论。《外台》癲病门中，亦无此说。则钱氏所谓五脏各有一兽云云，犹出唐人以后，殊不足据。总之，病为脑神经病，灼然无疑，又何必强以五脏妄为分别。且治法既同，尤可见分脏论症，穿凿附会，本无实在理由可言矣。此条歌诀，悉宗钱氏，殆以历代相沿，取其通俗耳。

第十五节 闻语言要诀

谵语为实，狂言怒詈；郑声为虚，如梦如呓。寒病懒

言，热病多语。言壮为实，言轻为虚。出言迟懒，先轻后重，内伤虚证；出言雄壮，先重后轻，外感邪盛。

[参] 语者，二人相对而谈也；言者，发声以表意思也。故发端曰言，答述曰语。凡小儿语言声音，不异于平时为吉，反者为凶。闻而知之者，寒主静则少语，热主烦则多语。虚则声细，实则声壮。他如言迟者风也。语言謇塞者，风痰也。声如从室中言者，中气之湿也。多言者，火之用事也。病未久而语声不续者，其中气本虚也。言而微终日乃复言者，正气夺也。衣被不敛，言语善恶，不避亲疏者，神明之乱也。诊时独言独语，不知首尾者，内伤心神也。此皆闻语言之大要也。若精而求之，则以五脏有五声，以合于五音者为常，变则病生。其义蕴载于《素问》《金匱》者居多，精研儿科学者，尤当悉心参考焉。

第十六节 闻臭味要诀

口喷臭秽，为牙疳证；咯痰腥臭，为肺痈证。大便酸臭，气难闻者，肠积热症；大便生腥，气清冷者，霍乱寒症。小便臭浊，为湿热症；小便味甜，为下消症。

[参] 清前哲王秉衡曰：闻字虽从耳，而四诊之闻，不专主于听声也。戴麟郊先生《广瘟疫论》，辨证最细。谓疫证必有秽浊之气，鼻官精者，可以闻而知之也。愚谓闻字实有二义，虽非疫证，凡入病室，五官皆宜并用。问答可辨其口气，有痰须询其臭味。榻前虎子（即溺器），触鼻可分其寒热。痈疡脓血，审气即知其重轻。

余如鼾息、肠鸣、矢气之类，皆当以耳闻者。古人但主乎呼歌呻哭数字，固矣。家严特增闻臭味要诀，非但补儿科学所未备，实为闻诊推广其义也。

第四章 按诊纲要

一按囟额，二按胸腹，三按冲任，四按手足，五按冷热，此皆要诀。从详分按，较脉准凿。

[参] 按者，谓以手下抑，抑按皮肉也。周于蕃曰：按而留之者，以按之不动也。按字从手从安，以手探穴而安于其上也。以言手法，则以右手大指面直接之，或用大指背屈而按之，或两指对过合按之。其于颅囟手足，则以三指按之。于胸腹，则以掌心按之。宜轻宜重，以当时相机行之。

第十七节 按囟额要诀

65

轻捻儿头，摸其颅囟，不作声者，则无病情。大小囟门，按之充实，其儿必寿，可为预测。大囟空虚，按之不实，或底或凹，禀虚之质。小囟虚软，按之不坚，禀赋血弱，多病难健。欲探其病，三指按额，仿诊脉例，外候最切。儿头在左，举左手候；儿头在右，举右手候。食指近发，则为上部；名指近眉，则为下部。外感温风，三指俱热；表里俱寒，三指冷冽。上热下寒，食中指热；设若大惊，名中指热；设若停食，食指独热。

[参] 首骨曰颅，脑盖曰囟。小囟，曰前囟门；大囟，曰后囟门。前清熊运英曰：前囟门，乃禀母血而

充；后囟门，乃受父精而实。若前后囟门充实，其儿必寿。如父之精气不足，耽嗜酒色，令儿后囟空虚不实。如母之原稟不足，血弱病多，令儿之前囟虚软不坚，多生疾病。如父母气血俱不足，其儿必夭，其父母亦不能保其天年也。前囟，即道家所谓泥丸宫。后囟，即脑顶门中名百会穴。前后囟门俱不合，名曰解颅，皆因先天精气之不足耳。此条首按颅囟者，盖因乳子初生，与儿童诊察各别，先探其稟受之虚实也。若按额法：于额前眉端发际之间，以名中食三指，照诊脉式，按而候之，此《幼科心鉴》相传之法。殆因乳子脉不可凭，故以此法代切脉耳。前清推拿专家，如夏氏卓溪《家传探病秘诀》云：以吾三指按儿额，感受温风三指热；三指按兮三指冷，内伤饮食风寒袭。可见以望为主之夏鼎，亦常用按法，以诊察乳孩之病也。

第十八节 按胸腹要诀

按胸之法，自胸及膈。拒按与否，可断虚实。其症虚者，软而喜按；其症实者，坚而怕按。按之硬痛，则为结胸；不痛而突，则为鸡胸。次按虚里，与脉相应。虚里高者，寸口亦高；寸口结者，虚里亦结。孩脉难凭，惟揣虚里。确有可据，能知病理。按有二候，浅按便得，深按却无，气虚之候；轻按洪大，重按虚细，血虚之候。按腹之要，以脐为先，脘与满腹，尤要摩勘，脐名神阙，神气之穴。重按有力，其气应手，神气内守；按之虚陷，如指入灰，神气失守。若按三脘，抚之不

滞，胃气平和，中无宿滞。凡满腹痛，喜暖手按，多属寒症；喜冷物按，多属热症。喜重按者，多属虚症；拒重按者，多属实症。

[参]《内经》谓胸腹者，脏腑之郭也。考其部位层次，胸上属肺，胸膺之间属心；其下有一横膈，绕肋骨一周，膈下属胃；大腹与脐属脾；脐四周又属小肠；脐下两腰属肾；两肾之旁及脐下，又属大肠；膀胱亦当脐下，故脐下又属膀胱；血室乃肝所司，血室大于膀胱，故小腹两旁，谓之少腹，乃血室之边际，属肝；少腹上连季肋，亦属肝；季肋上连肋骨，属胆。胸与腹向分三停，上停名胸，在膈上，心肺包络居之，即上焦也。膈下为胃，横曲如袋，胃下为小肠，为大肠，两旁右为肝胆，左为脾，是为中停，即中焦也。脐以下为下停，有膀胱，有冲任，有直肠，男有外肾，女有子宫，即下焦也。故胸腹为五脏六腑之宫城，阴阳气血之发源。若如其脏腑何如，则莫如按胸腹，名曰腹诊。腹诊之法，详见于《难经·四十八难》杨玄操丁德用注。此医家四诊之外，不可缺之事也。但历代医书，未见有详论者。张志聪《伤寒论集注》云：中胃按之而痛，世医便谓有食，夫胃为水谷之海，又为仓廩之官，胃果有食，按必不痛。试将饱食之人，按之痛否？惟邪气内结，正气不能从膈出入，按之则痛。又胃无谷神，脏气虚而外浮，按之亦痛。若不审邪正虚实，概谓有食，伤人必多。又按者轻虚平按，若按不得法，加以手力，未有不痛者。又患肿胀腹满之症者，视其腹之形色，按其腹之坚软。再或幼科童稚，未免伤于食者，故亦按之，此挽近诊腹

之一法也。乃近世专门儿科，独望闻问三诊，而不按胸腹；亦未免草率之甚矣。凡按胸腹，医必先温其手，否则病儿受惊，腹壁变硬，不能达诊断之目的。尤宜按摩数次，或轻或重，或击或抑，以察胸腹之坚软，拒按与否，并察胸腹之冷热，灼手与否，以定其病之寒热虚实。又如轻手循抚，自胸上而脐下，知皮肤之润燥，可以辨寒热。中手寻扪，问其痛不痛，以察邪气之有无；重手推按，察其硬否，更问其痛否，以辨脏腑之虚实，沉积之何如，即诊脉中浮中沉之法也。虽然胸腹部之脏器甚多，即其一器，有视诊、触诊、打诊、听诊，及检查内容物等区别，故欲一一述之，非数十章不可。今试以最简单最紧要之学说，略述一二于次。

一、小儿胸廓诊法。胸廓为心肺二神所居之宫殿，其形状如何，急宜注意。年龄加长后，见其宫殿此处曲屈，彼处洼下，则难乎为治矣。然在幼稚之小儿，尚可急起而矫正之。其次胸廓膨大如桶，或如鼓身，名曰膨胸。呼吸时胸廓缩张甚少者，为肺气肿。反之锁骨上下凹入，肋骨根露出外方，肩胛骨张离若翼者，名曰缩胸。为肺癆质，有结核素因之人，乃若是也。又有一侧膨胀者，为一侧之气肿。或有一侧缩小者，为肋膜炎之病后也。

二、腹部诊法。宜使小儿裸体仰卧，集合其两足于一处为要。然在暖室法不备之家，则易罹寒冒，不得已，任小儿着衣服，以手由股间伸入而检查之。若腹部膨胀且硬者，大约为便通不足，或胃扩张，或胃肠病等。若其胀法甚强，手所感之抵抗力非常大者，是或为

鼓肠腹水腹膜炎等。如果为鼓肠，则手抚之如压气枕也。如果为腹水，则当有液体之波动。如果为腹膜炎，则虽稍触之，其痛甚烈者也。其次为下腹之右方，有大痛，手上觉有块物或瘤样者，是可断之为盲肠炎。又小儿啼泣不止，似其腹部甚痛，以手压之，则觉其痛渐缓者，概为胃痛肠痛，较不足恐惧者也。但是上等感觉，均非熟练之结果，不能辨别之，读者幸勿为轻率之判断也。至若虚里，在左乳三寸下，脉之宗气也，即左心房尖与总脉管口衔接之处。以手按之，可察心机之强弱，及其心房之麻痹，故按胸之后，必按虚里。按之微动而不应者，宗气内虚。按之跃动而应衣者，宗气外泄。按之应手，动而不紧，缓而不急者，宗气积于膈中，是为常。按之弹手，洪大而搏，或绝而不应者，皆心胃气绝也，病不治。虚里无动脉者必死，即虚里搏动而高者，亦为恶候。魏柳州云：凡治小儿，不论诸证，宜先按虚里穴，若跳动甚者，不可攻伐，以其先天不足也。幼科能遵吾言，造福无涯，此千古未泄之秘也，珍之贵之。多纪菑庭曰：痘疹发热疑似者，诊虚里，其动亢盛及缺盆者，痘也。此动无者，他病也。余得此诀于小川柅斋，而验之果然。南阳曰：脉候有热，而腹候无热者，是表热，而其热易去也。按腹而热如烧手掌者，是伏热，而其热不易去也。小儿暴热，其轻重难以脉辨，而诊腹可以决定矣。若心下动而其热烙手者，尤不可忽。玄祐曰：小儿蛔病，诊腹有三候：腹有凝结如筋而硬者，以指久按，其硬移他处，又就所移者按之，其硬又移他处，或大腹，或脐旁，或小腹，无定处，是一候

也。右手轻轻按腹，为时稍久，潜心候之，有物如蚯蚓蠢动，隐然应手，甚至腹底微鸣，是二候也。高低凸凹，如畎亩状，熟按之起伏聚散，上下往来，浮沉出没，是三候也。合而观之，腹诊之重要如此，宜乎东洞吉益曰：腹为有生之本，百病之根，故诊病必按其腹。富士川氏曰：听诊打诊等，诊断法未备之时，腹诊实为唯一之诊断法。和田启十郎云：此言以听打二诊，与腹诊同一视之，稍有差误，其实听打只于呼吸血行二器病有效，余皆不见其用。独腹诊为诊定病之发于腹内诸器，影响于身体各部者之最大要法。而疾病中十之七八，悉由其腹部所生，故东洞先生之言，为不诬也。

第十九节 按冲任要诀



按冲任脉，分部细诊，左动属冲，右动属任。冲动病剧，里急气逆，上冲作咳，为厥为呃。任脉动跃，阳盛阴虚，男结七疝，女则癥聚。久泻久痢，冲任动跃，其病皆危，医弗用药。

[参]《内经》谓冲脉任脉，皆起于胞中，上循背里，为经络之海，其浮而外者，循腹右上行，会于咽喉，别而络唇口。《伤寒论》谓之脐间动气。李志锐所谓饮食入胃，取汁变赤，由营卫上入于心，由心分布其重浊之汁，入冲脉化血，精华之汁，入任脉化精，冲是一身之总血管，任是一身之总精管者是也。凡按诊脐间动脉者，密排右三指，或左三指，以按脐之上下左右，动而和缓有力，一息二至，绕脐充实者，肾气充也。一

息五六至，冲任伏热也。按之虚冷，其动沉微者，命门不足也。按之热燥，其动细数，上支中腕者，阴虚气冲也。按之分散，一息一至者，为元气虚败。按之不动，而指如入灰中者，为冲任空竭之候。且可辨其假寒假热，按冲任脉动而热，热能灼手者，症虽寒战咬牙，肢厥下利，是为真热而假寒。若按腹两旁虽热，于冲任脉久按之无热而冷，症虽面红口渴，脉数舌赤，是为真寒而假热。总之，冲任脉动，皆伏热伤阴。阴虚火动之证，平人则发病，病人则难治。惟素有肝热者，亦常有之，尚无大害。若素禀母体气郁，一病温热夹食，肠中必有积热，热盛则冲任脉动。动而低者热尚轻，动而高者热甚重，兼虚里脉亦动跃者必死。如能积热渐下，冲任脉动渐微，及下净而冲任脉不动者多生。若冲任脉跃震手，见于久泻久痢者，乃下多亡阴之候，病终不治。

第二十章 按手足要诀

先按其手，指冷如冰，伤风兼寒；指梢头热，夹食伤寒。手如数物，势将抽掣；手撒不收，症多脱绝。掌中寒者，腹中亦寒，掌中热者，腹中亦热。手背热者，背上亦热，为新感证；手心热者，小腹亦热，为伏气证。指甲青者，心痛肝绝；指甲黑者，血瘀筋绝；若指甲白，久病虚极。次按其足，足心热者，多属热证；足胫冷者，多属寒证。仰睡脚伸，亦属热证；覆卧脚蜷，亦属寒证。足冷而晕，气虚脱证；足肿至跗，气虚寒证。按其手足，手热足冷，汗多妄言，为暑湿病；头疼发

热，为夹阴病。

〔参〕手者，人体上肢之总名也，凡所以持物者多称手。足者，人体下肢之总名也，凡所以踢物者多称足。《难经》谓手三阴之脉从手至胸中，手三阳之脉从手至头，足三阴之脉从足至胸，足三阳之脉从足至头。观此，则手足之寒热，关系于经络之运行，血脉循环之所及也。夏禹铸曰：指爪属筋余，脾为之运，小儿指尖冷，主惊厥。中指独热者属寒，中指独冷者，分男左女右，为痘疹发见之象，其或掌心冷，而十指或开或合者无治。周于蕃曰：小儿拳四指已握，而大指加于四指上者，男顺女逆，小儿拳大指先屈入掌中，而四指加于大指上者，女顺男逆。小儿拳将大指插入食指叉而后握之，无论男女急慢惊风，均属险症，三岁内以至十岁外，皆可以此决之。张筱衫曰：脾主四肢，四肢厥逆，有寒有热，三阴证四肢厥冷，人所习见者，寒厥也。厥，尽也。阳尽而阴生，故四肢冷也。若热厥较寒厥尤多，经云热深厥亦深，热微厥亦微，同此厥逆，寒热攸分，生死立判，以之辨证，则手足尤为至要。

第二十一节 按冷热要诀

凡证冷热，按而得之。遍身俱热，外感无疑。肚热脚冷，伤食须知。脚热额冷，因惊致斯。耳足皆寒，头身发热，恐为痘疹，辨宜精切。

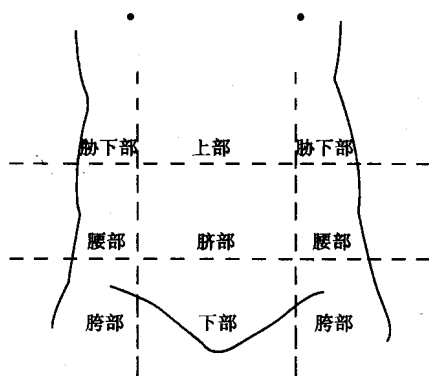
〔参〕似此诊法，一按便知，故不赘述。

腹与胸分三停，上停名胸，在膈上，心肺包络居

之。心与包络，从著脊处油膜中，下通肝肾。肺有薄衣，连及胸内，前面之膜，为肺通中下焦之路，肺系上连包络，后著脊，前连胸膈。肝体即在膈下。胃附肺系，透下膈，横曲如袋。胃下为小肠，为大肠，为肝胆，是为中停。皆生连油膜之上，即中焦也。脐以下为下停，有膀胱，有胞宫，有直肠，皆生连油膜上，即下焦也。后世不知焦从腠，因不知通身之膜，皆是三焦。故读经文者，少识精义。西医曰，腹内统膜，一丽腹里，一包脏腑，一成筋以束脏腑。肝、胃、脾、小肠、大肠、横回、直肠上截、子宫蛋核，彼此遮过。专包一脏曰包膜，兼包两脏曰连膜，折叠成筋以束肝腑曰筋膜。西医言膜如此其详，证以三焦之说，而精义始出。

腹分九部。上一横，当第九两肋骨。下一横，当两胯骨上廉。两直皆由腠筋中处起，直上至离乳头少许止。上曰上部，中曰脐部，下曰下部。上左右曰肋下部，中左右曰腰部，下左右曰胯部，上部，藏胃中并幽门、肝左叶、后叶、四合回管、肝脉、肝回管、胆管、腹短总脉、甜核总脉、总回管、总吸管、肋总回管。脐部，藏大肠横回、脂囊小肠、包膜小肠、上中下回。下部，藏小肠、膀胱、子宫（孕时方有）。右肋下部，藏肝右叶、胆囊、小肠上回、大肠上回、右肾上半、右肾上核。左肋下部，藏胃大端、脾甜核端、大肠下回、左肾上半、左肾上核。右腰部，藏大肠上回、右肾下半、小肠。左腰部，藏大肠下回、左肾下半、小肠。右胯部，藏大肠头、阑门、肾溺管、卵子脉回管。左胯部，藏大肠弯回、肾溺管、卵子脉回管。

腹九部图



第五章 检诊纲要

一检口腔，二检温度，三检阴器，四检便路（即肛门），此时检查，慎毋粗卤。

[参] 检，查验也。如检查、检察，即留意稽察之谓也。当检察儿病之际，务须将小儿位置稳妥，或抱或卧，俱可听便，且勿令其啼泣，以啼泣则有碍检查也。若儿年甫两三岁者，检查时，嘱旁人捉其两手，且捧住头颅，如此对窗坐下，方能检视。若在夜间，则用反射镜为宜。然医者必须五官并用，先检视小儿之体格、体质、容貌、肤色、眼球之若何、发疹之有无、呼吸次数之多少、肢节之运动及位置。次听其咳嗽与声音之奚若。又次查问其曾出天花与否，曾患脓漏眼与否，脐带剪断时，曾有意外之疾患与否。又次闻其口气之臭味若何，此皆必不可少之检法也。

75

第二十二节 检口腔要诀

指探其口，儿不发声，从容咂指，多属轻症；如不咂指，即发啼声，或哭无泪，多属重症。若儿气急，痰涎塞口，或作鸦声，状若鱼口，或人中黑，黑色绕口，似此危症，皆属死候。重捺其唇，儿自张口，得以检视，察其咽喉，上腭起粒，状类乳头，脐风将发。锁肚噤

口，喉关起白，白屑满口，吮乳不得，是谓鹅口。

〔参〕口腔咽头之检查，为小儿诊断中必不可少者。初生儿之口内黏膜，多充血，呈暗赤色，唾液之分泌殊少，故口腔干燥，舌带白苔。欲令乳儿张口，可以手指触其下唇等部，儿误以为乳头，往往张口，此时宜即以指探入，抵压舌根，而速检视各部。若儿因检查而啼泣，转得以视察口内，检查齿牙，亦为诊断病症之一助。如营养不良之小儿，其生齿多迟徐。遗传霉毒之小儿，其齿别有殊特之形，所谓忽珍巽氏（ホツチンソン）齿也。具此齿形者，其化骨恒不全，故齿色或褐，或暗黄，细狭短小，厥状似栓，齿缘多不平直，两隅间有巨大之洼凹，其内端更生一二小洼凹。又检查小儿口中之舌苔，亦为最要之见症。如舌肿至舌边仅留齿痕者，诸种口内炎皆属之。其尤肿胀肥大者，急性舌实质炎。其他肿疡，或舌内静脉血淤滞所起之重症也。舌缩小者，为肠室扶斯，其他重症，急性热性病。且其舌常干燥，舌常震动者，为重症热性病，此肠室扶斯及精神有异常之症也。舌色苍白者，为贫血之症。赤色者，为急性热性病。赤中带黑如覆盆子状者，概为猩红热也。有舌苔者，未必为病人，大人之健全者，若饮酒吸烟过多，则亦有舌苔，若真为疾病者，消化不良时所起之舌苔也。蒋仲芳曰：小儿二三岁，身热惊悸，易医六七，俱无寸效，一日忽作鸦声，少顷，其音已哑，鱼口开张。予视之，欲哭状，惟眉头稍皱，终无音出，心甚怜之，细思其策，因以指探其口中，唇干舌燥。予曰：心热欲言而不能果有之乎。即以黄连、黄芩、石膏、麦

冬、山梔、玄参、花粉、知母、甘草、薄荷、灯芯、竹叶等，一大剂，煎成浓膏，频频与之，一昼夜而鸦声复出，又一日而音始痊而愈。自此之后，此法治人无算。大便三四日不行者，加玄明粉二三钱，尤验。惊悸者，加金器同煎。嗟乎！人遇哑惊风，俱弃之而不治，孰知唇干舌燥，终属阳症，此法甚验，故记之。连类观之，则检查口腔法之必要也明矣。

第二十三节 检温度要诀

检温之法，或以手按，或用器检，俱可听便。温度高者，多属实热，温度低者，多属虚热。温度极高，固属险极；温度极低，尤为急逆。

[参] 小儿并不啼泣，而颜貌不快者，必检察其发热与否。其法以手掌按小儿之额，或胸腹，或手足等处，试其体热如何。然大人之手，若时而极冷，时而过暖，则往往遗误，惟口唇之感觉，比手锐敏，与手互相比，可以不生误谬，故可谓小儿之天然检温器。但人之感觉，亦因练习而发达，不经验之人，虽用此器，犹未必可谓确实也。然则如之何而可？曰：手掌与口唇，均仅知其概要耳，欲精密检查者，固必用真检温器者也。其法与大人同，亦插于腋窝内。但小儿之天性，或欲取之，或恶厌之，或有时时啼泣，不便诊察者，宜从背后插入该器，为亲者，以手防其脱出，给以玩具，或抱之使睡，勿使惊动为要。但检查小儿之体温，以手掌贴于前额胸腹四肢等部分，试其肌热为最简便。如须用

检温器，则亦在腋窝为最普通。但勿令目睹，宜自背部暗地插入，且须用手维持，防其脱落。在未满一岁之小儿，则在直肠内检测亦可。小儿体虽易冷（例如儿患肺炎其经过多无热），然因他故而热度升腾，常有至摄氏四十度以上者。惟儿发高热，非必定属险症。如因小儿霍乱，血行障碍而假死、虚脱等而体温下降过甚者，乃险症也。凡普通小儿之体热，在摄氏三十六度七分与三十七度四分间，若检温器示摄氏四十度，则宜延医服药。升至摄氏四十四五度，下至摄氏三十三度五分，则将永辞人世矣。为亲者，宜记之勿忘。若医者来检察时，亦以其睡眠中为最佳，若任小儿啼泣，而无理以手插入者，亦不可谓小儿科专门医也。抑插检温器之时间，约十分，欲迅速测之者，可涂油于检温器，而以其尖入诸肛门内，约五六分时，然须知其温度比腋窝中高半度也。

第二十四节 检阴器要诀

婴孩阴器，男则外凸，女则内凹，检验不忒。肝火下逼，形肿色赤。光亮如吹，水气内结。心火下移，外肾肿赤，玉门胀大，一检便悉。

[参]《内经》谓厥阴脉循阴器而络于肝，阴器者，男女之生殖器也。临症所能检视者，在男孩为阴茎，其根起自膀胱之尖端，附丽于耻骨之前侧，全体皆属海绵质，中有水道，尿液由此排泄焉。其次阴囊，所以容辜丸者。由皱襞体二部合成，中有膜以隔之，内分为左右

二部，左部略较右部下垂。在女婴为阴唇，阴唇者，在女子之外阴部，有大阴唇、小阴唇之别。大阴唇为生殖器外口之两侧，小阴唇在大阴唇之内侧。故医者检视阴茎阴囊阴唇者，可以知诸种病症之若何也。

第二十五章 检便路要诀

直肠下口，名曰魄门，大便之路，通称肛门。湿热下逼，肛痒异常。气虚下陷，肛脱而长。湿火成毒，虫生蚀肛。蚀肛透内，婴孩必伤。

[参] 隋·巢元方曰：肺与大肠为表里，肛者，大肠之门，肺实热则闭结不通，肺虚寒则肠头出露。有因痢久，里急后重，努力肛开，为外风所吹；或伏暑作泻，肠滑不禁；或禀气怯弱，易于感冷，亦致大肠虚脱。陈藏器曰：小儿肛痒，或嗜甘肥，大肠湿热壅滞；或湿毒生虫而蚀肛门。若因病不食，虫无所养而食脏食肛者，其齿龈无色，舌上尽白，四肢倦怠。其上唇内有疮，吐血如粟，心中懊恼，此虫在上食脏。若下唇有疮，此虫在下食肛。若食肛透内者，不治。要诀但据其简单者而言，他如用显微镜检查粪便，因以知寄生虫之有无；以分析法检验小便，因以知蛋白质之多少，又皆必不可少者也。

第六章 切脉纲要

三岁以上，血脉循环（可诊来去至止之脉状），诊以一指，约为三关（小儿臂短，难以布其三指，以分三关也，只可以一指诊之）。六七为平，八九为数。数为风热，癰疽应作。浮洪胃热，弦劲肝风，沉紧腹痛，迟弱虚中。人迎紧盛，伤寒之候；气口紧盛，伤食之咎。二至三至，九至十余，太过不及，险逆可虞。五岁以上，密下三指。十三岁后，少壮一致。

[参]《小儿卫生总微论》曰：凡儿禀受脏腑气血，荣卫形体，虽有生皆全。然于未语之前，变蒸之际，则气血未充，肤革未固，筋骨未坚，脉状未成，若有病也，难为诊切，又难访问，是以先贤言婴小之病难治者，以无承据也，故立其观视形色之法焉。儿自生积五百七十六日，大小变蒸数毕，则气血荣，精神异，筋骨壮，脉理全，然后方可诊切，又能言问也。或谓小儿之脉，与壮老不同者，是不达诊治之大体也。虽然，多证识脉，非实地练习，临症时心心相传授者，不能了解其脉理。今试略述小儿之切脉法。生后未满一月之健康小儿，其脉一分时间，百二十乃至百四十搏。由是次第减少，二岁时约百搏；三岁至十岁间，约九十搏；十五岁以上，乃与成人无异，平均为七十三四搏。检小儿之脉，宜在睡眠中。盖小儿受纤微之刺激，即如哺乳啼泣

等，即增加脉数故也。夫脉之为物，概因热度之高低，而增减其搏数，普通热上升一度，脉约加增十搏（大人增八搏）。然若热甚高，而脉数仍少且缓，则其症为非常重大，详审因证以辨明之，恐其并发脑膜炎故也。反之，无热而脉搏突突加进者，恐为心脏瓣膜病，亦不可不注意之。又若本为高热，而其后渐渐下降，甚至降至普通以下，脉搏多而细小，则可爱之小儿，当为心脏衰弱，或心脏麻痹而死矣。

小儿之脉，宜定至息，二至为殃，三至亦卒，五卒为虚，四至损怯，六至平和，九十至剧。浮缓伤风，浮洪风热，浮紧伤寒，沉细乳积，沉紧腹痛，弦紧喘急，紧促痘疹，急惊弦疾，虚软慢脾，疟痢弦急，弦细为虫，便秘数实。

[参] 《内经》谓壅遏营气，令无所避，是谓脉。脉，血管也，由心房跳动，分布周身，使血之流行循环不穷者。发血者曰动脉，回血者曰静脉。中医切脉，名曰脉息。西医诊脉，名曰脉搏。凡人体中由心脏而来之血液，成为波流，因动脉管之弹力，使脉跳动也。惟小儿之脉，非比大人之烦琐，但察其强弱缓急，即可中紫。盖强弱可以察虚实，缓急可以见邪正，四者既明，无论何证，随病合脉，皆可适当。试述其要如下：①审形象。小儿一岁后，可用一指转侧，辨其三部脉之弦缓浮沉。一息六七至者为平和，八九至为发热，五至为内寒。弦为风痫，沉缓为伤食，促急为虚惊，弦急为气不和，沉细为冷，浮为风。大小不匀为恶候，为惹祟。浮大数为热，伏为积聚，单细为疳癆。腹痛多喘呕而脉洪

者，为有虫。沉而迟，潮热者，为胃寒。②辨逆顺。（甲）惊搐之脉，浮数为顺，沉细为逆。（乙）夜啼之脉，微小为顺，洪大为逆。（丙）心腹痛之脉，沉细为顺，浮大为逆。（丁）伤寒之脉，洪弦为顺，沉细为逆；浮大为顺，微伏为逆。（戊）汗后之脉，沉细为顺，洪紧为逆。（己）温病之脉，洪大为顺，沉细为逆。（庚）咳嗽之脉，浮滑为顺，沉细为逆。（辛）霍乱之脉，浮洪为顺，迟微为逆。（壬）吐衄之脉，浮大为顺，沉细为逆。（癸）泄泻之脉，缓小为顺，浮大为逆。（子）下利之脉，沉细为顺，浮大为逆。（丑）诸渴之脉，洪细为顺，微细为逆。（寅）诸肿之脉，浮大为顺，沉细为逆。（卯）腹胀之脉，浮大为顺，虚小为逆。（辰）痰喘之脉，滑大为顺，沉细为逆。（巳）寒热之脉，紧数为顺，沉细为逆。（午）疳癆之脉，紧数为顺，沉细为逆。（未）虫痛之脉，紧滑为顺，浮大为逆。（申）失血之脉，沉细为顺，浮数为逆。（酉）中恶腹胀之脉，紧细为顺，浮大为逆。（戌）黄疸之脉，浮大为顺，沉细为逆。（亥）丹毒之脉，浮洪为顺，沉细为逆。

第二十六节 切头颈脉要诀

两额两颈，以及耳前，三部动脉，按切为先。浮动而强，外感邪气；沉动而弱，内伤正气。邪盛则实，正夺则虚，既明虚实，遑问其余。

[参] 凡全体搏动之处，皆可切脉。要诀先述在上三部者，法遵《内经》。经谓上部天，两额之动脉，天

以候头角之气；上部地，两颈之动脉，地以候口齿之气；上部人，耳前之动脉，人以候耳目之气。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三而成人，三而三之，合则为九。张景岳《类经》注云：额旁动脉，当颌厌之分，足少阳脉气所行也。两颈动脉，即地仓大迎之分，足阳明脉气所行也。耳前动脉，即和髎之分，手少阳脉气所行也。故两额动脉以候头角，两颈动脉以候口角，耳前动脉以候耳目。上部中部下部，各有天地人，是为三部九候，按：此为全体上部脉之三部九候也。要诀首先切头颈脉者，盖因小儿之气，上盛于头，凡有外感，其症每先发现于头部也。曾祖秀山公《读医随笔》云：两颈动脉，即人迎脉，经文误作两颊，恐系传讹，颊改作颈为适当。故家严新增要诀，两颊遂改为两颈。

第二十七节 切手臂脉要诀

初以中指，定关为则，次以两指，按寸与尺。寸部法天，主头脑分，关部法人，主胸腹分；尺部法地，主腰足分。凡此每部，有浮中沉，三三九候，别阳与阴。浮以候腑，沉以候脏，中候胃气，切记毋忘。人长脉长，人短脉短；性急脉急，性缓脉缓。男子尺弱，女子尺盛，此皆为常，反之者病。每指之下，轻重消息，无徒孟浪，务求真得。复以三指，齐按消除，候其来往，接续何如。脉为血府，息属气机，脉不自动，气实使之。故曰脉者，气血之先，虚实寒热，脉随应焉。凡医诊

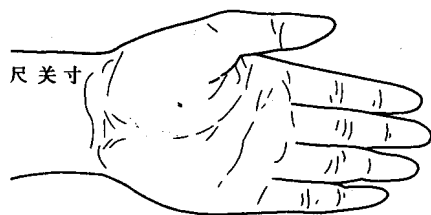
脉，平心定气，气息平调，后乃下指。浮沉迟数，细大短长，大纲既得，逐部推详。

[参]切手臂脉者，即《内经》所谓中部天，天以候肺，手太阴也。张氏《类经》注云：掌后寸口动脉，经渠之次，肺经脉气所行也。然脉之为道，最为微妙，往往心中已了，指下难明。前清张心在先生著《持脉大法》，取八脉为纲，皆以显然可见者为据。一曰浮，浮者，轻手著于皮肤之上而即见，为表病也。一曰沉，沉者，重手按于肌肉之下而始见，为里病也。浮沉二脉，以手之轻重得之，此其显而易见也。一曰迟，迟者，一息脉来二三至或一息一至，为寒病也。一曰数，数者，一息脉来五六至或一息七八至，为热病也。迟数二脉，以息之至数辨之，又显而易见也。一曰细，细者，脉状细小如线，主诸虚之病也。一曰大，大者，脉状粗大如指，主诸实之病也。细大二脉，以形象之阔窄分之，又为显而易见也。一曰短，短者，脉来短缩，上不及于寸，下不及于尺，为素禀之衰也。一曰长，长者，脉来迢长，上至鱼际，下至尺泽，为素禀之盛也。长短二脉，以部位之过与不及验之，又为显而易见也。又有互见之辨，浮而数为表热，浮而迟为表寒；沉而数为里热，沉而迟为里寒。又于表里寒热四者之中，审其为细，则属于虚；审其为大，则属于实。又须于表里寒热虚实六者之中，审其为短，知为素禀之衰，疗病须兼培其基址；审其为长，知为素禀之盛，攻邪必务绝其根株，此凭脉治病之秘法也。

掌后高骨为关，关前为寸，关后为尺。凡诊脉视掌后高骨下指，先关后寸尺。人短则指密排，人长则指疏

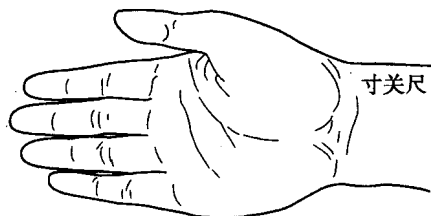
排，为一定之法。

左寸关尺图



左寸表小肠里心，主上焦；
左关表胆里肝，主中焦；
左尺表膀胱里肾，主下焦。

右寸关尺图



右寸表大肠里肺，主上焦；
右关表胃里脾，主中焦；
右尺表心包里命门，主下焦。

第七章 总括六诊纲要

形色苗窍，望而知之；声音呼吸，闻而知之；病源症候，问而知之；胸腹胸腹，按而知之；口腔温度，检而知之；脉搏状态，切而知之。临症断病，六诊兼施。

[参] 前清王孟英曰：急症险症，疑难杂症，往往脉候难凭，必须细查病源，详审舌苔，按其胸腹，验其二便，汇参默察，则寒热虚实之真假，庶可得其真谛也。虽然，脉诊能知病势血气运行之变态，与夫病之所在，及全身受病之大要。按诊能知腹内病根聚积之所，察知他处之影响。检诊能知体温之寒热，气血之虚实。病有以脉变为主者，症有以腹状为本者，有验之于按诊而益明者，有征之于检诊而益确者，合之望闻问三诊，为六诊法。不可偏重，亦不可偏轻。儿科专家，能于此六种诊断学，精而求之，神而明之，临症治病，六诊兼施，则于儿科诊断术，无间然矣。

第八章 辨证纲要

第二十八节 辨外感内伤要诀

病起外因，统名外感；病起内因，通称内伤。属外感者，有寒有热；属内伤者，有虚有实。寒热之候，伤风最多；虚实之候，乳食最多。

[参] 清儿科大家叶香岩曰：婴儿肌肉柔脆，不耐风寒，脏腑气弱，乳汁难化，内外二因之病自多，然有非风寒竟致外感者，四时之伏气也。不停滞已属内伤者，遗传之胎病也。前清儿科名家蒋仲芳曰：近世庸工治病，皆不先辨其外感内伤之因，予不揣愚陋，先将二因说明于后，使学者一目了然。①凡见婴儿，身偃母怀，发热惊啼，头疼鼻塞，咳嗽声重者，皆属外感。怕风自汗者伤风，恶寒无汗者伤寒。夏令吐泻口渴，面垢齿燥者伤暑。身重神倦，便泄溺涩者伤湿。秋深发热咳嗽，痰粘声哑者伤燥。面赤唇焦，口燥舌干者，伤伏火之温热。②凡见小儿，暖气呕酸，恶心恶食，发寒发热，乍吐乍泻，手心胸腹皆热，下泄臭屁，嗔煎不安者，皆属内伤乳食。以上二因为最多，故先提其要而述之。

第二十九节 辨寒热虚实要诀

一面眇白，二眼珠青，三肚虚胀，四睡露睛，五足胫冷，六粪青白，寒症有七，吐泻无热，宜温宜补，切忌清泄。一面腮红，二眼白赤，三渴不止，四上气急，五大大便秘，六溺黄色，热症有七，手足心热，忌温忌补，最宜清泄。皮寒气少，饮食不入，泄利前后，脉细欲绝，此为五虚，皆宜补益。皮热腹胀，神气闷瞀，前后不通，脉盛而数，此为五实，皆宜攻夺。

[参] 蒋仲芳曰：外感内伤既明，尤必辨其寒热虚实。①凡见婴儿，面白唇青，手足冷，口气冷；或泄利清白，无热不渴，腹痛悠悠无增减；或恶心呕吐，喜就暖处，脉来沉迟无力者，俱属寒症。②凡见婴儿，发热，手足心热，面红唇干，舌燥口渴，口上生疮，口中热臭，大便秘，小便赤黄；或痢下黄赤，肛门焦痛，喜饮冷水，腹中热痛，喜就冷处，脉来洪数者，皆属热症。③凡见婴儿，面眇白无神，懒言气短，不欲乳食，腹膨不痛，二便如常，神倦喜卧，眼喜闭，睡露睛，手足无力；及久吐胃虚，久泻脱肛脾虚，自汗表虚，自利里虚，脉来微细无力；与夫行迟，发迟齿迟，解颅，鹤膝，多由肾气未充，元阴不足者，俱属虚症。④凡见婴儿，发热无汗者表实，腹热便秘者里实，心胸饱闷，腹中膨胀，恶心暖气，吐出酸水，手足有力，腹痛手不可按，两脉洪实有力者，俱属实症。以上诸症，每病不必悉具，凡见二三，便作主张治之。若三症四症兼见者，

须照本条斟酌尽善，自能中病也。

第三十节 辨表里外内要诀

寒热虚实，病机之纲；表里外内，病位之常。凡儿百病，各有特征，头项背腰，可察表证；面目九窍，可察里证；血脉睛舌，可察内证。辨明变化，以定标准。

[参]《周礼》曰：两之以九脏之动，参之以九窍之变。此即临证辨病位之标准也。上编诊断总括，已一一明辨之。惟病位之表里内外，东医和田氏，颇有发明，试节述其言曰：中医分病之所在，有表里内外之别，皮肤为表，气管肺胃肠为里。合表里谓之外，血肉骨髓谓之内。盖人体之形状，不过上有口，下有肛门之一空洞，左右两侧，连以手足者。洞之外面曰表，内面曰里，实质曰内，表里不与外界相通，名之曰外，故如皮肤气管肺胃肠等为外位。实质不与外界相通，名之曰内，故如血肉骨髓等为内位。然身体上之各器官，非独立无关系者，皮肤与胃肠互相表里（排泄作用），肺与气管互相表里（呼吸作用），肺与皮肤肾脏互相表里（排水作用），肝胆脾与胃肠互相表里（消化作用），口与肝门互相表里（出纳作用），乳房与子宫互相表里（育儿作用）。诸器又各有表里之别也，故皮肤之排泄有障碍者，胃肠起呕吐下痢。皮肤之呼吸有障碍者，肺气管起咳嗽咯痰。皮肤妨碍蒸发者，肾脏利尿加多。鼻孔肿塞者，肺气管喘息咳嗽。十二指肠输胆管发加答儿□者，成黄疸病。便秘过度者，呕吐。子宫郁血者，乳房

结肿。其妙用盖笔舌不能尽也。然病毒之进行，始必侵及表位，继则侵入里位，攻及表里犹未治，则更陷入内位。迨病毒满于内外，即为九死一生之症。故医者之治病，必明病毒之所在处，尽力以攻表。表不治，则攻里。若表里均不治，不能禁其不内陷，则一发千钧，甚为危殆。夫病毒由表而里而内，身体之自然疗能，常欲驱病毒于最易外逸之表位，若不能，则为险恶症状。不得其遁走之途，迫而为内陷症状，故内陷症，即血中饱受病毒（トキシン）所起之剧烈障碍状态。故若有杀灭病原菌之确效方法，兼用他方消散霉菌之毒素，或强盛细胞之抗毒力，则为万全而无一失。而杀菌必知霉菌之所在，消散毒素及强盛抗毒力，必知病位之关系。中西医所有杀菌方法，不过数种，其余皆在消散毒素，强盛抗毒力。故中医之病位说，不可不三致意也。



第三十一节 辨机变形势要诀

先述病机，约二十条，诸风掉眩，皆属于肝；诸寒收引，皆属于肾；诸湿肿满，皆属于脾；诸气膹郁，皆属于肺（喻嘉言曰：此指燥病而言）；诸痛痒疮，皆属于心。（此风寒湿燥火五条分属五脏主证）诸痿喘呕，皆属于上（谓上焦心肺之燥病）；诸厥固泄，皆属于下（谓下焦肝肾之寒病）。诸暴强直，皆属于风（足厥阴肝经风证）。水液清冷，皆属于寒（足少阴肾经寒证）。诸病有声，鼓之如鼓，皆属于热（手太阴肺经热证）；诸转反戾，水液浑浊，皆属于热（手太阳小肠经热证）；

诸呕吐酸，暴注下迫，皆属于热（足少阳胆经热证）；诸胀腹大，皆属于热（足太阴脾经热证）。诸痉项强，皆属于湿（足太阳膀胱经湿证）。诸涩枯涸，干劲皴揭，皆属于燥（刘河间《原病式》增补）（肺胃肠三经燥证）。诸病跗肿，疼酸惊骇，皆属于火（手阳明大肠经火证）；诸禁鼓栗，如丧神守，皆属于火（手少阴心经火证）；诸逆冲上，皆属于火（手厥阴心胞络经火证）；诸热瞽瘈，皆属于火（手少阳三焦经火证）；诸躁狂越，皆属于火（足阳明胃经火证）。

[参] 观《内经》病机十九条，前五条，各属五脏之病；次二条，兼咳上下之病；后十二条，分隶十二经证。其中除五脏上下外，其间属火者五，属热者四，此外惟风寒湿三气而已。独缺皆属于燥一条，故刘氏《原病式》增补之，谓在外则皮肤皴揭，在上则咽鼻生干，在中则水液衰少而烦渴，在下则肠胃枯涸津不润而便难，在手足则痿弱无力，在脉则细涩而微，此皆血液为火热所伤，其言如此。其实《生气通天论》谓：秋伤于燥，上逆而咳，发为痿厥。燥病之要，可一言而终。张戴人云：休治风兮休治燥，治得火时风燥了。斯治燥之要，亦一言而终也。由是观之，四时六淫病之多属于热证火证者，证之经旨而益明矣。况在生气极旺、蓬蓬勃勃、体属纯阳之小儿乎！前清叶天士云：六气之邪，皆从火化。饮食停留，郁蒸变热，惊恐内迫，五志动极皆阳，故襁褓小儿，所患热病为最多。真儿科大家博历知病之言。

次言病变，推原其因，迁延时日，杂药误投，变态

百出。如有所夹，更多变症。或挟伏气，或夹内伤。别病累瘁，传变无常。

〔参〕变症者，于本症外忽生别症也。临症实验以来，除病家失治，医家误治者外，惟因伏邪为最多。前清张路玉云：邪热不尽，伏留脏腑经脉之间，致变他病不一。如邪火伏于脾，则变中满不食，伏于胃，移热于肠，则变休息痢。伏于心，移热于小肠，则变淋血溺痛，痛甚则小便不通，多不可治。伏于肝，则变囊痈阴肿，伏于肺，则变肺痈吐腥。伏于肾，则变羸瘦怯弱。伏于脾肾之间，则变瘫卧不起，久而成痿。伏于肝脾之分，邪正交攻，则变疟疾。至若太阳少阳失汗，则毒结腮颊之间，变为发颐。阳明少阳失下，则邪结于脏腑之内，变成痈肿。旨哉言乎！故治病之道有二：一曰逐机，二曰持长。逐机为见主症变化，随机应变之谓。持长为主症未变化前，常用一方以断病根之谓。汉医大家东洞翁，谓医生无定见者，常从患者之言及病变，而加减药方；有定见者，不从患者之言，虽发变症，而知其为药剂之反应，非定症有变化，决不妄易原方。

又次病形，经称病能，古名外候，今名症状。举其大端，既往症状，现在症状。现症之中，约计有五，自觉症状，他觉症状，直达症状，介达症状，指定症状。究其缘由，详其情状，辨其异同，审其变状。

〔参〕徐洄溪曰：凡病之总者谓之病，而一病必有数症，如太阳伤风，是病也，其恶风身热，自汗头痛，是症也，合之而成其为太阳病，此乃太阳病之本症也。若太阳病，而又兼泄泻不寐，心烦痞闷，则又为太阳病

之兼症矣。如疟病也，往来寒热，呕吐畏风，口苦，是症也，合之而成为疟，此乃疟之本症也。若疟而兼头痛胀满，咳逆便秘，则又为疟疾之兼症矣。若疟而又下痢数十行，则又不得谓之兼症，谓之兼病。盖疟为一病，痢又为一病，而二病又各有本症，各有兼症，不可胜举。以此类推，则病之与症，其分并何啻千万，不可不求其端而分其绪也。且有病同症异者，有症同病异者，有症与病相因者，有症与病不相因者。盖合之则曰病，分之则曰症，后之医者，病之总名亦不能知，安能于一病之中，辨明众症之渊源。即使病者身受其苦，备细言之，而彼实茫然，不知古人以何药为治，仍以泛常不切应命，并有用相反之药，以益其疾者，此病者之所以无门可告也。江苏周威曰：症状者，生活现象之异常变化也。别为自觉症状及他觉症状二种，自觉症状，为病人自己所知觉者，例如头痛眩晕、疲劳饥渴等。然其感觉之轻重，因人而异。精神病及初生儿等，则大都不能有自觉症。所谓他觉症状者，指由医师所检知者而言，如脉搏、呼吸、尿粪、血液、体柔等性质状态之变化是也。又有直达症状与介达症状之别，从罹病脏器直接发现之症状，曰直达症状。例如肺病之呼吸困难，心脏病之全身郁血，肾脏病之尿量减少、蛋白尿。介达云者，自罹病脏器间接发现之症状。例如肾脏病之全身水肿，肺病之全身郁血等是也。其他更有所谓指定症状者，即确实表示疾病性质之症状，例如 Kpoup 性肺炎之锈色痰，Aaaisoni 氏病之皮肤黄铜色，肾脏炎之蛋白尿圆柱等是也。

又次病势，约分六种，阴阳虚实，表里内外，主客本末，顺逆轻重，此六病端，有一不同，处方选药，切弗侏侗。

[参] 日本汉医学家和田氏曰：病有形有势，势现于先而常变，形备于后而不变。势者末也，影也。形者本也，体也。例如肠室扶斯有肠室扶斯之定型，赤痢有赤痢之定型，是谓之形。病初起时隐隐，其盛也烈烈，其衰也微微，是谓之势。治病者，当依形以断病症，依势以决治法，故为医者，须先知病之形势。今也西医之论病形，即已不遗余力。而病势则不然。中医由症候配合多味之药，其论病形，虽不及西医周到，而论病势则过之。余闻观今治疗医学，所谓有特效者，仅不过数种病名而已，其他多数之疾病，仍不能不用对症疗法治之，而欲行对症疗法，非潜心考察病势不可。故病形取法于西洋，病势取法于中邦，则庶几得治术之大本矣。

第三十二节 辨儿病险症要诀

小儿险症，虽若可畏，太溪脉动，眼有神气，凶门如常，面爪不异，此犹可救，处方注意。

[参] 险症者，处于顺症逆症之间者也，其病在可顺可逆之分际，皆可谓之险症。试以胎毒一端，罕譬而喻之，毒气轻者固顺，然必儿之气血不虚，则始为顺也；重者固逆，亦必儿之气血虚，则始为逆也。毒微者顺也，若儿之气血虚弱，虽顺恐化险也；毒甚者逆也，若儿之气血不虚，虽逆能变顺也。此以儿之胎毒重轻，

气血虚实，定病势之顺逆险也。此时若疗法适当，看护周到，虽险症亦可转顺。若疗法不当，看护不周，则其病险者变逆。逆者更逆，其结果必凶多吉少矣。

第三十三节 辨儿病逆症要诀

肢体俱冷，汗珠凝身，爪青面黯，眼直无神，啼声如鸦，鼻燥生尘，囟忽肿陷，喉响痰升，病形至此，皆为逆症，药虽对证，难望求生。

[参] 逆症较险症为更急，故逆症即急症。但有虚与实之分，有误治之急症者，多属虚症；有逆治之逆症者，多属实证。试征诸和田氏之言曰：凡病顺行者为常，急逆者为变。失常而疾行者曰急，失常而逆行者曰逆。凡急逆之变，虽有发于诸种疾病初期者，然多为治术不与自然病势相应所起之变症。例如疝痢、五更泻、二阳合病下痢等，起于胃肠运化不足，非起于肠内聚积病毒者，宜乎冷者温之，热者清之，以药剂巩固胃肠，为至当之治法。然若谓不扫除腹内之病毒，则病根不尽，宜投下剂以廓清之，则其痢益急，莫知所止，死于肉脱厥冷困急之下，此即由误治致急症者也，故名曰急。此时之急症，与虚症相一致。又如赤痢、疫痢、热毒下痢等，起病之初，病原菌所酿成之病毒，充满于肠内，宜先之以通利剂，扫荡腹内之郁毒，而后以调理剂作后疗法，乃为至当之顺序。若不先扫荡病毒，而惟下痢之是恐，先防遏之，则死于腹满热盛苦闷之下，是即由逆治致逆症者也，故名曰逆。此时之逆症，与实症相

一致。要之急与逆虽分虚实，除急性传染病外，皆非普通发病之状态，多因误其治法所生之变症也。古贤所以设此变态，以论病势者，欲医者不误治法，而其既因误治，有此等变态者，速为救变之策耳。明医张安世曰：顺险逆之三症，顺则无庸治，逆则治何益，惟险者在急治，而尚变通，其机不暇少缓，宜急攻则急攻，宜峻补则峻补，不可泥于轻可去实之一法，仍以疲药塞责，耽误婴童生命也。

第三十四节 辨五脏绝症要诀

吐泻变痢，血黑难当（心主血，心绝则血色变黑，虚燥而发渴），瘦难行坐，舌不缩藏（心主舌，绝则不能收），脸如脂赤（痢久则面当无色，今面色反如脂者，心绝则虚阳上发也），不语口疮（心主舌，绝则不能语），心脏绝症，危急异常。

〔参〕凡小儿病见败象，断其不治，通称绝症。如凶肿或陷，汗出不流，或如珠如油，舒舌出口，舌肿发惊，发直如麻，肤无血色，泻血黑黯，此心绝也，壬癸日死。

眼目时闭，浑似醉人，频频要睡，心烦多嗔（肝主目，绝则不能开，故涩而只要睡；又肝主筋，力绝则如醉人不能举也；又肝主怒，绝则多怒不止也），唇白胞肿，狂啼躁声，肝绝危症，难望回春。

〔参〕唇口润动，啼哭无泪，或不哭泪下，眼深如陷，爪甲青黑，舌卷囊缩，肢搐目斜，手如抱头之状，

此肝绝也，庚辛日死。

面黄虽好，只怕相残，肢厥畏寒，蛔上觅餐（脾主肢体，绝则体弱；又脾绝则肾逆乘之，故发憎寒；脾绝则胃热，故虫不安而上吐出），吮乳无力，盖齿为难（脾主唇，绝则不能收掩其齿，又不能吮乳），眶陷胞瘰（眼眶属脾，绝则倾陷），脾绝难挽。

[参] 人中平满，或现黑色，唇缩反张，焦枯燥裂，或见紫黑，或不盖齿，舌缩或卷，鼻孔开张，冷涎如油，撮口如囊，面如土色，四肢逆冷，吮乳不受，咽物喉鸣，泻粪赤黑，小便溺血，此脾绝也，甲乙日死。

肺候色白，怕见绝形，鼻青孔黑，腹胀胞倾（肺主鼻，绝则肝逆乘之而色青；又肺绝则无涕，故孔黑燥也；肺主眼胞，绝则陷之），项直气急，胸突声痞（肺主气，绝则喘急项直以引气也；气绝则胸中满凸，但有出气而无回气也），肺脏绝症，断难望生。

97

[参] 目直青鲜，气喘不续，食物噎嗽，痰涎塞口，喉中鸣响，鼻塞不通，鼻干黑燥，肺胀胃膈，头汗肢冷，此肺绝也，丙丁日死。

冷汗时出，尿多夜惊（肾绝则阴阳相离，故冷汗出而小便不禁；精者神之舍，绝则精神离，故夜里多惊，肾属阴，夜亦属阴故也），遍身生疥，肢冷如冰（阳不能充暖故也），项倒头倾，面黑无神（肾绝则天柱骨倒，面目皆黑无精神），肾脏绝症，必殒其身。

[参] 面黑神昏，眼黑胞肿，目无光彩，耳轮青黄，焦枯痞瘦，牙齿脱落，发疏黄燥，皮肤枯黑，惊风咬乳，戛齿下气，黑色绕口，此肾绝也，戊己日死。

以上小儿五种绝症，家严从前哲乔岳五脏绝症歌，斟酌其间，编为要诀以增订之。

第三十五节 辨婴童死症要诀

眼上赤脉，下贯瞳人，凶门肿起，兼及作坑，鼻干黑燥，肚大青筋，目多直视，都不转睛，指甲黑色，忽作鸦鸣，虚舌出口，啮齿咬人，鱼口气急，啼不作声，蛔虫既出，必是死形，用药速急，十无一生。

[参] 此晋太医令王叔和“小儿死证歌”，近时儿科诸书，均未载述，家严从《小儿总微论》中采补以新增之。他如通真子《小儿死候歌》曰：凶陷唇干目直视，口中冷气卧如痴，身形强直手足软，掌冷头低尽莫医。总之为小儿医者，先将辨症纲要第八章，一一记诵而熟练之，临症时，庶不为小儿病所欺矣。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=小儿诊法要义

作者=何廉臣著

页数=98

S S 号=11968617

出版日期=2008.1

封面
书名
版权
前言
目录

第一章	望诊纲要
第一节	观形当诊体格
第二节	察色当参神气
第三节	望面部形色
甲、	面现五色原理
乙、	面色断病总诀
丙、	面色察症要诀
丁、	面分五部总诀
戊、	面上五部热病
己、	面诊五部形色要诀
第四节	望苗窍形色
甲、	察两耳形色要诀
乙、	察两目形色要诀
丙、	察鼻孔形色要诀
丁、	察口唇齿形色要诀
第五节	验舌苔形色要诀
第六节	察溲便形色要诀
第七节	望指纹形色
甲、	辨指纹三关要诀
乙、	辨指纹左右要诀
丙、	辨指纹浮沉要诀
丁、	辨指纹三关病势要诀
戊、	辨指纹弯向病状要诀
己、	辨指纹各色要诀
庚、	辨指纹淡滞要诀
辛、	辨色脉合参要诀
第二章	问诊纲要
第八节	问病因要诀
第九节	问诊十法要诀
甲、	问寒热要诀

乙、问汗要诀
丙、问头身要诀
丁、问胸间要诀
戊、问饮食要诀
己、问睡眠要诀
庚、问饥渴要诀
辛、问溲便要诀
壬、问旧病要诀
癸、问遗传要诀

第三章 闻诊纲要

第十节 闻声音要诀
第十一节 闻啼哭要诀
第十二节 闻呼吸要诀
第十三节 闻咳嗽要诀

第十四节 闻痛声要诀
第十五节 闻语言要诀
第十六节 闻臭味要诀

第四章 按诊纲要

第十七节 按囟额要诀
第十八节 按胸腹要诀
第十九节 按冲任要诀
第二十节 按手足要诀
第二十一节 按冷热要诀

第五章 检诊纲要

第二十二节 检口腔要诀
第二十三节 检温度要诀
第二十四节 检阴器要诀
第二十五节 检便路要诀

第六章 切脉纲要

第二十六节 切头颈脉要诀
第二十七节 切手臂脉要诀

第七章 总括六诊纲要

第八章 辨证纲要

第二十八节 辨外感内伤要诀
第二十九节 辨寒热虚实要诀

- 第三十节 辨表里外内要诀
- 第三十一节 辨机变形势要诀
- 第三十二节 辨儿病险症要诀
- 第三十三节 辨儿病逆症要诀
- 第三十四节 辨五脏绝症要诀
- 第三十五节 辨婴童死症要诀